



www.turkishstudies.net/turkishstudies

Turkish Studies

eISSN: 1308-2140

Research Article / Araştırma Makalesi



ANKARA SCIENCE
UNIVERSITY

A New and Holistic Approach to the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder: Narrative Exposure Therapy

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Tedavisinde Yeni ve Bütüncül bir Yaklaşım: Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi

Fatma Aysazcı Çakar*

Abstract: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is a serious mental health condition in which individuals develop physical and psychological symptoms following traumatic experiences. Various therapeutic approaches are currently used in the treatment of it, with Cognitive Behavioral Therapies and Prolonged Exposure Therapy being among the most empirically supported methods. In recent years, however, Narrative Exposure Therapy (NET) has emerged as a promising approach, particularly for treating complex trauma. The purpose of this article is to explain the theoretical foundations of NET, a trauma-focused approach widely used worldwide, to evaluate its effectiveness through literature review, and to increase its use by experts and in Türkiye. NET is a holistic therapeutic model that aims to help individuals process traumatic events in a safe environment by chronologically structuring their life narratives. This method integrates multiple techniques, including exposure therapy, testimony therapy, and autobiographical memory reprocessing. Research has demonstrated the effectiveness of NET in reducing PTSD symptoms among refugees, war survivors, torture victims, and domestic violence survivors. Additionally, it has been successfully applied to a broader population, including natural disaster victims, individuals with childhood trauma, survivors of sexual violence, and offenders. The implementation of NET involves constructing a life timeline, symbolizing life events using flowers and stones, detailing traumatic experiences, and engaging in therapeutic reconstruction processes. With its structured and time-limited format, NET is considered a viable option for both clinical and field applications. It is particularly valuable in high-trauma regions and for professionals working with limited resources. This study explores the theoretical foundations, application process, and effectiveness of NET, discussing its potential as an alternative approach for PTSD treatment. Furthermore, the importance of expanding its use in Türkiye is emphasized.

Keywords: Psychology, Narrative Exposure Therapy, Posttraumatic Stress Disorder, Trauma-Focused Interventions, Psychological Counseling

Öz: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, bireylerin travmatik yaşantılar sonrasında fiziksel ve psikolojik belirtiler geliştirdiği ciddi bir ruh sağlığı sorunudur. Günümüzde TSSB'nin tedavisinde çeşitli terapi yaklaşımları kullanılmakta olup özellikle Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisinin etkililiği

* Lecturer Dr., Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education, Department of Psychological Counseling and Guidance
Öğr. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Buca Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2629-1470>
fatma.aysazcicakar@deu.edu.tr

Cite as/ Atıf: Aysazcı Çakar, F. (2026). A new and holistic approach to the treatment of post-traumatic stress disorder: narrative exposure therapy / Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde yeni ve bütüncül bir yaklaşım: Anlatısal maruz bırakma terapisi. *Turkish Studies*, 21(2), 2357-2400. <https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.86723>

Received/Geliş: 05 August/Ağustos 2025

Accepted/Kabul: 20 March/Mart 2026

Published/Yayın: 25 March/Mart 2026

Checked by plagiarism software



kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, son yıllarda Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi (Narrative Exposure Therapy, NET) özellikle kompleks travmanın tedavisinde umut verici bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu kuramsal makalenin amacı; Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan travma odaklı bir yaklaşım olan NET'in teorik temellerinin açıklanması, literatürdeki çalışmalarla etkiliğinin değerlendirilmesi, tekniğin uygulanması ve Türkiye'de kullanımının yaygınlaştırılmasının önemini tartışmaktır. NET, bireylerin yaşam öyküsünü kronolojik olarak yapılandırarak, travmatik olayları güvenli bir ortamda tekrar işlemelerini sağlamayı amaçlayan bütüncül bir terapi modelidir. Bu yöntem; maruz bırakma teknikleri, şahitlik terapisi ve otobiyografik belleği yeniden işleme gibi farklı teknikleri birleştirerek kullanmaktadır. Araştırmalar, NET'in mülteciler, savaş mağdurları, işkence gören bireyler ve aile içi şiddet mağdurları gibi gruplarda TSSB semptomlarını azaltmada etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, doğal afet mağdurları, çocukluk çağı travması yaşayan bireyler, cinsel şiddet mağdurları ve suç failleri gibi geniş bir popülasyonda da başarılı olduğu kanıtlanmıştır. NET'in uygulanışı; bireyin yaşam çizgisinin oluşturulması, yaşam olaylarının çiçek ve taşlarla sembolleştirilmesi, travmatik olayların detaylandırılması ve terapötik yeniden yapılandırma süreçlerini içermektedir. Teknik, kısa süreli ve standardize edilmiş yapısıyla hem klinik hem de saha uygulamaları için uygun bir seçenek sunmaktadır. Özellikle travmanın yoğun olduğu bölgelerde ve sınırlı kaynaklarla çalışan profesyoneller için etkili bir müdahale aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada ise; NET'in teorik temelleri, uygulama süreci ve etkililiği ele alınarak, TSSB tedavisinde nasıl bir alternatif sunduğu tartışılmıştır. Özellikle Türkiye'deki uygulamalar açısından bu yöntemin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Travma Odaklı Terapiler, Psikolojik Danışmanlık

Structured Abstract:

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is a debilitating mental health condition that arises following exposure to traumatic events, often resulting in persistent psychological and physiological symptoms. Traditional therapeutic approaches such as Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Prolonged Exposure Therapy (PE) have long been considered gold-standard treatments for PTSD. However, recent years have witnessed the emergence of Narrative Exposure Therapy (NET) as a promising alternative, particularly for individuals with complex trauma histories and those living in high-trauma regions with limited access to mental health resources.

NET is a structured, short-term, and integrative therapeutic model that combines principles from CBT, testimony therapy, client-centered psychotherapy, and neurotraumatology. Its core objective is to help individuals reconstruct their autobiographical memory by integrating traumatic experiences into a coherent life narrative. This is achieved through a symbolic and ritualized process involving the construction of a “lifeline,” where life events are represented using physical symbols chronologically—flowers for positive experiences and stones for traumatic ones. This method does not only facilitate emotional processing but also empowers individuals to reclaim agency over their life stories.

The theoretical foundation of NET is rooted in the Dual Representation Theory of Memory, which posits that traumatic memories are stored in two distinct systems: “hot” memory (emotional and sensory components) and “cold” memory (contextual and factual details). Traumatic experiences often disrupt the integration of these systems, leading to fragmented and intrusive recollections. NET aims to reprocess these memories by activating both systems in a safe therapeutic environment, thereby reducing PTSD symptoms and restoring narrative coherence. The therapy also draws upon the Emotional Processing Model, emphasizing the importance of habituation and cognitive restructuring in trauma recovery.

NET is implemented through four structured phases: (1) Assessment and psychoeducation, (2) Lifeline construction, (3) Narrative elaboration of life events, and (4) Final reading and consolidation. During these sessions, the therapist plays a critical role in facilitating detailed recall, maintaining emotional safety, and ensuring the integration of fragmented memories. The process is designed to be flexible and adaptable to the individual’s trauma history, cultural background, and psychological needs.

Empirical evidence from randomized controlled trials has demonstrated the efficacy of NET across diverse populations, including refugees, survivors of war, torture, domestic violence, and natural disasters. Studies have shown significant reductions in PTSD symptoms, depression, anxiety, and stress among participants. Adaptations of NET such as KIDNET (for children), FORNET (for offenders), and e-NET (for online delivery) further highlight the versatility and scalability of the approach. These formats have been successfully applied in various cultural contexts, including African refugee settlements, post-tsunami regions in Sri Lanka, and among survivors of political imprisonment in Eastern Europe.

In the context of Türkiye, where exposure to trauma is prevalent due to natural disasters, migration, and socio-political factors, NET holds significant potential. Despite its proven effectiveness, the application of NET in Türkiye remains limited. Preliminary research involving Syrian refugees has shown promising results, indicating reductions in PTSD, depression, anxiety, and improvements in self-concept clarity. These findings underscore the need for further research, cultural adaptation, and dissemination of NET in clinical and community settings across the country.

The article concludes by emphasizing the importance of expanding NET’s use in Türkiye, particularly in regions with high trauma exposure and limited mental health infrastructure. It advocates for the integration of NET into public health systems, training of mental health professionals, and the development of culturally sensitive protocols to enhance its accessibility and effectiveness. By doing so, NET can serve as a valuable tool in addressing the psychological aftermath of trauma and promoting resilience among affected populations.

Keywords: Psychology, Narrative Exposure Therapy, Posttraumatic Stress Disorder, Trauma-Focused Interventions, Psychological Counseling.

ملخص منظم:

هو حالة صحية عقلية موهنة تنشأ بعد التعرض لأحداث صادمة، وغالبًا ما تؤدي (PTSD) اضطراب ما بعد الصدمة والعلاج (CBT) إلى أعراض نفسية وفسيولوجية مستمرة. لطالما اعتُبرت الأساليب العلاجية التقليدية مثل العلاج السلوكي المعرفي ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة ظهور العلاج بالتعرض السردى PTSD. العلاجات المعيارية لـ (PE) بالتعرض المطول كبديل واعد، خاصة للأفراد الذين لديهم تاريخ معقد من الصدمات النفسية وأولئك الذين يعيشون في مناطق تعاني من (NET) صدمات نفسية شديدة مع موارد محدودة للصحة العقلية.

والعلاج (CBT) هو نموذج علاجي منظم وقصير الأجل وتكاملي يجمع بين مبادئ العلاج السلوكي المعرفي NET بالشهادة والعلاج النفسي المتمركز حول العميل وعلم الصدمات العصبية. ويتمثل هدفه الأساسي في مساعدة الأفراد على إعادة بناء ذاكرتهم الذاتية من خلال دمج التجارب الصادمة في سرد متماسك لحياتهم. ويتحقق ذلك من خلال عملية رمزية وطقوسية تنطوي على بناء "خط حياة"، حيث يتم تمثيل أحداث الحياة باستخدام رموز مادية مرتبة ترتيبًا زمنيًا — الزهور للتجارب الإيجابية والحجارة للتجارب الصادمة. ولا تسهل هذه الطريقة المعالجة العاطفية فحسب، بل تمكن الأفراد أيضًا من استعادة السيطرة على قصص حياتهم.

إلى نظرية التمثيل المزدوج للذاكرة، التي تفترض أن الذكريات الصادمة يتم تخزينها في NET تستند الأساس النظري لـ نظامين متميزين: الذاكرة "الساخنة" (المكونات العاطفية والحسية) والذاكرة "الباردة" (التفاصيل السياقية والوقائعية). غالبًا ما إلى إعادة معالجة NET تؤدي التجارب الصادمة إلى تعطيل تكامل هذين النظامين، مما يؤدي إلى ذكريات مجزأة ومتطفلة. تهدف هذه الذكريات من خلال تنشيط كلا النظامين في بيئة علاجية آمنة، وبالتالي تقليل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة واستعادة تماسك السرد. يعتمد العلاج أيضًا على نموذج المعالجة العاطفية، الذي يؤكد على أهمية التعود وإعادة الهيكلة المعرفية في التعافي من الصدمة.

من خلال أربع مراحل منظمة: (1) التقييم والتثقيف النفسي، (2) بناء خط الحياة، (3) التفصيل السردى NET يتم تنفيذ لأحداث الحياة، و (4) القراءة النهائية والتوحيد. خلال هذه الجلسات، يلعب المعالج دورًا مهمًا في تسهيل التذكر التفصيلي، والحفاظ على الأمان العاطفي، وضمان تكامل الذكريات المجزأة. تم تصميم العملية لتكون مرنة وقابلة للتكيف مع تاريخ الصدمة الفردية والخلفية الثقافية والاحتياجات النفسية.

عبر مجموعات سكانية متنوعة، بما في ذلك NET أثبتت الأدلة التجريبية من التجارب العشوائية المضبوطة فعالية اللاجئين والناجون من الحروب والتعذيب والعنف المنزلي والكوارث الطبيعية. أظهرت الدراسات انخفاضًا كبيرًا في أعراض FORNET (للأطفال) و KIDNET مثل NET اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق والتوتر بين المشاركين. تبرز تعديلات (للتسليم عبر الإنترنت) تنوع هذا النهج وقابليته للتطوير. وقد تم تطبيق هذه الأشكال بنجاح في سياقات e-NET (للمجرمين) و ثقافية مختلفة، بما في ذلك مستوطنات اللاجئين الأفارقة، والمناطق التي تعرضت لكارثة تسونامي في سريلانكا، وبين الناجين من السجن السياسي في أوروبا الشرقية.

في سياق تركيا، حيث ينتشر التعرض للصدمات بسبب الكوارث الطبيعية والهجرة والعوامل الاجتماعية والسياسية، تتمتع في تركيا محدودًا. أظهرت الأبحاث الأولية التي NET بإمكانيات كبيرة. على الرغم من فعاليتها المثبتة، لا يزال تطبيق NET شملت لاجئين سوريين نتائج واعدة، تشير إلى انخفاض في اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق وتحسن في وضوح مفهوم في البيانات السريرية والمجتمعية في جميع NET الذات. تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى مزيد من البحث والتكيف الثقافي ونشر أنحاء البلاد.

في تركيا، لا سيما في المناطق التي تنتشر فيها الصدمات النفسية NET يختتم المقال بالتأكيد على أهمية توسيع استخدام في أنظمة الصحة العامة، وتدريب المتخصصين في الصحة NET وتكون البنية التحتية للصحة العقلية محدودة. وتدعو إلى دمج أداة قيمة في NET العقلية، ووضع بروتوكولات تراعي الثقافة لتعزيز إمكانية الوصول إليها وفعاليتها. وبذلك، يمكن أن تكون معالجة الآثار النفسية للصدمة وتعزيز المرونة بين السكان المتضررين.

الكلمات المفتاحية: علم النفس، العلاج بالتعرض السردى، اضطراب ما بعد الصدمة، التدخلات التي تركز على الصدمة، الاستشارة النفسية.

Résumé structuré:

Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est un trouble mental invalidant qui survient à la suite d'une exposition à des événements traumatisants et qui entraîne souvent des symptômes psychologiques et physiologiques persistants. Les approches thérapeutiques traditionnelles telles que la thérapie cognitivo-

comportementale (TCC) et la thérapie par exposition prolongée (PE) ont longtemps été considérées comme les traitements de référence pour le SSPT. Cependant, ces dernières années ont vu l'émergence de la thérapie par exposition narrative (TEN) comme une alternative prometteuse, en particulier pour les personnes ayant des antécédents traumatiques complexes et celles vivant dans des régions à fort taux de traumatismes avec un accès limité aux ressources en santé mentale.

La TEN est un modèle thérapeutique structuré, à court terme et intégratif qui combine les principes de la TCC, de la thérapie par le témoignage, de la psychothérapie centrée sur le client et de la neurotraumatologie. Son objectif principal est d'aider les individus à reconstruire leur mémoire autobiographique en intégrant leurs expériences traumatiques dans un récit de vie cohérent. Pour ce faire, elle utilise un processus symbolique et ritualisé qui consiste à construire une « ligne de vie », où les événements de la vie sont représentés à l'aide de symboles physiques classés par ordre chronologique : des fleurs pour les expériences positives et des pierres pour les expériences traumatiques. Cette méthode facilite non seulement le traitement émotionnel, mais permet également aux individus de reprendre le contrôle de leur histoire personnelle.

Le fondement théorique de la NET est ancré dans la théorie de la double représentation de la mémoire, qui postule que les souvenirs traumatiques sont stockés dans deux systèmes distincts : la mémoire « chaude » (composantes émotionnelles et sensorielles) et la mémoire « froide » (détails contextuels et factuels). Les expériences traumatiques perturbent souvent l'intégration de ces systèmes, entraînant des souvenirs fragmentés et intrusifs. La NET vise à retraiter ces souvenirs en activant les deux systèmes dans un environnement thérapeutique sûr, réduisant ainsi les symptômes du SSPT et rétablissant la cohérence narrative. La thérapie s'appuie également sur le modèle de traitement émotionnel, qui souligne l'importance de l'accoutumance et de la restructuration cognitive dans le rétablissement après un traumatisme.

La NET est mise en œuvre en quatre phases structurées : (1) Évaluation et psychoéducation, (2) Construction d'une ligne de vie, (3) Élaboration narrative des événements de la vie, et (4) Lecture finale et consolidation. Au cours de ces séances, le thérapeute joue un rôle essentiel en facilitant le rappel détaillé, en maintenant la sécurité émotionnelle et en assurant l'intégration des souvenirs fragmentés. Le processus est conçu pour être flexible et adaptable à l'histoire traumatique, au contexte culturel et aux besoins psychologiques de chaque individu.

Des preuves empiriques issues d'essais contrôlés randomisés ont démontré l'efficacité de la NET auprès de diverses populations, notamment les réfugiés, les survivants de la guerre, de la torture, de la violence domestique et des catastrophes naturelles. Des études ont montré une réduction significative des symptômes du SSPT, de la dépression, de l'anxiété et du stress chez les participants. Les adaptations de la NET telles que KIDNET (pour les enfants), FORNET (pour les délinquants) et e-NET (pour la prestation en ligne) soulignent encore davantage la polyvalence et l'évolutivité de l'approche. Ces formats ont été appliqués avec succès dans divers contextes culturels, notamment dans les camps de réfugiés africains, dans les régions touchées par le tsunami au Sri Lanka et parmi les survivants d'emprisonnement politique en Europe de l'Est.

Dans le contexte de la Turquie, où l'exposition aux traumatismes est fréquente en raison des catastrophes naturelles, des migrations et des facteurs sociopolitiques, la NET présente un potentiel important. Malgré son efficacité prouvée, l'application de la NET en Turquie reste limitée. Des recherches préliminaires menées auprès de réfugiés syriens ont donné des résultats prometteurs, indiquant une réduction du syndrome de stress post-traumatique, de la dépression et de l'anxiété, ainsi qu'une amélioration de la clarté du concept de soi. Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre les recherches, l'adaptation culturelle et la diffusion de la NET dans les milieux cliniques et communautaires à travers le pays.

L'article conclut en soulignant l'importance d'étendre l'utilisation de la NET en Turquie, en particulier dans les régions où l'exposition aux traumatismes est élevée et où les infrastructures de santé mentale sont limitées. Il préconise l'intégration de la NET dans les systèmes de santé publique, la formation des professionnels de la santé mentale et l'élaboration de protocoles adaptés à la culture afin d'améliorer son accessibilité et son efficacité. Ce faisant, la NET peut constituer un outil précieux pour traiter les séquelles psychologiques des traumatismes et promouvoir la résilience parmi les populations touchées.

Mots-clés: Psychologie, thérapie d'exposition narrative, syndrome de stress post-traumatique, interventions axées sur les traumatismes, conseil psychologique.

Resumen Estructurado:

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es una afección de salud mental debilitante que surge tras la exposición a eventos traumáticos y que a menudo provoca síntomas psicológicos y fisiológicos persistentes. Los enfoques terapéuticos tradicionales, como la terapia cognitivo-conductual (TCC) y la terapia de exposición prolongada (PE), se han considerado durante mucho tiempo los tratamientos de referencia para el TEPT. Sin embargo, en los últimos años ha surgido la terapia de exposición narrativa (TEN) como una alternativa prometedora, especialmente para personas con historiales traumáticos complejos y aquellas que viven en regiones con altos índices de trauma y acceso limitado a recursos de salud mental.

La TEN es un modelo terapéutico estructurado, a corto plazo e integrador que combina principios de la TCC, la terapia del testimonio, la psicoterapia centrada en el cliente y la neurotraumatología. Su objetivo principal es ayudar a las personas a reconstruir su memoria autobiográfica integrando las experiencias traumáticas en una narrativa coherente de su vida. Esto se consigue mediante un proceso simbólico y ritualizado que implica la construcción de una «línea de vida», en la que los acontecimientos vitales se representan cronológicamente mediante símbolos físicos: flores para las experiencias positivas y piedras para las traumáticas. Este método no solo facilita el procesamiento emocional, sino que también empodera a las personas para que recuperen el control sobre sus historias de vida.

La base teórica de la NET se fundamenta en la teoría de la doble representación de la memoria, que postula que los recuerdos traumáticos se almacenan en dos sistemas distintos: la memoria «caliente» (componentes emocionales y sensoriales) y la memoria «fría» (detalles contextuales y fácticos). Las experiencias traumáticas a menudo alteran la integración de estos sistemas, lo que da lugar a recuerdos fragmentados e intrusivos. La NET tiene como objetivo reprocesar estos recuerdos activando ambos sistemas en un entorno terapéutico seguro, reduciendo así los síntomas del TEPT y restaurando la coherencia narrativa. La terapia también se basa en el modelo de procesamiento emocional, que enfatiza la importancia de la habituación y la reestructuración cognitiva en la recuperación del trauma.

La NET se implementa a través de cuatro fases estructuradas: (1) Evaluación y psicoeducación, (2) Construcción de una línea de vida, (3) Elaboración narrativa de los acontecimientos de la vida, y (4) Lectura final y consolidación. Durante estas sesiones, el terapeuta desempeña un papel fundamental a la hora de facilitar el recuerdo detallado, mantener la seguridad emocional y garantizar la integración de los recuerdos fragmentados. El proceso está diseñado para ser flexible y adaptable al historial traumático, los antecedentes culturales y las necesidades psicológicas de cada persona.

Las pruebas empíricas de ensayos controlados aleatorios han demostrado la eficacia de la NET en diversas poblaciones, incluyendo refugiados, supervivientes de guerras, torturas, violencia doméstica y desastres naturales. Los estudios han demostrado una reducción significativa de los síntomas de TEPT, depresión, ansiedad y estrés entre los participantes. Las adaptaciones de la NET, como KIDNET (para niños), FORNET (para delincuentes) y e-NET (para la prestación de servicios en línea), ponen aún más de relieve la versatilidad y la escalabilidad de este enfoque. Estos formatos se han aplicado con éxito en diversos contextos culturales, como los asentamientos de refugiados africanos, las regiones afectadas por el tsunami en Sri Lanka y entre los supervivientes de encarcelamientos políticos en Europa del Este.

En el contexto de Turquía, donde la exposición al trauma es frecuente debido a los desastres naturales, la migración y los factores sociopolíticos, la NET tiene un potencial significativo. A pesar de su eficacia demostrada, la aplicación de la NET en Turquía sigue siendo limitada. Las investigaciones preliminares con refugiados sirios han mostrado resultados prometedores, que indican una reducción del trastorno de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad, así como una mejora en la claridad del concepto de uno mismo. Estos hallazgos subrayan la necesidad de seguir investigando, adaptando culturalmente y difundiendo la NET en entornos clínicos y comunitarios de todo el país.

El artículo concluye haciendo hincapié en la importancia de ampliar el uso de la NET en Turquía, especialmente en regiones con alta exposición al trauma y una infraestructura de salud mental limitada. Aboga por la integración de la NET en los sistemas de salud pública, la formación de profesionales de la salud mental y el desarrollo de protocolos culturalmente sensibles para mejorar su accesibilidad y eficacia. De este modo, la

NET puede servir como una herramienta valiosa para abordar las secuelas psicológicas del trauma y promover la resiliencia entre las poblaciones afectadas.

Palabras clave: Psicología, Terapia de exposición narrativa, Trastorno por estrés postraumático, Intervenciones centradas en el trauma, Asesoramiento psicológico.

结构化摘要:

创伤后应激障碍（PTSD）是一种因暴露于创伤事件后引发的严重精神健康问题，常导致持续性心理及生理症状。认知行为疗法（CBT）和持续暴露疗法（PE）等传统治疗手段长期被视为PTSD的金标准疗法。然而近年来，叙事暴露疗法（NET）作为一种充满希望的替代方案应运而生，尤其适用于具有复杂创伤史的个体以及生活在高创伤地区且心理健康资源有限的人群。

NET是一种结构化、短期、综合性的治疗模式，融合了CBT、证词疗法、以客户为中心的心理咨询和神经创伤学原理。其核心目标是通过将创伤经历融入连贯的人生叙事，帮助个体重建自传体记忆。该疗法采用象征性仪式化过程——构建“生命线”，以实体符号按时间顺序呈现人生事件：鲜花代表积极经历，石块象征创伤体验。这种方法不仅促进情感处理，更赋予个体重获人生叙事主导权的力量。

NET的理论根基植于记忆双重表征理论，该理论认为创伤记忆存储于两个独立系统：“热”记忆（情感与感官成分）和“冷”记忆（情境与事实细节）。创伤经历常导致这两套系统整合失调，引发片段化与侵入性回忆。NET旨在通过在安全治疗环境中激活双系统来重构记忆，从而减轻PTSD症状并恢复叙事连贯性。该疗法同时借鉴情绪处理模型，强调习惯化和认知重构在创伤康复中的重要性。

NET通过四个结构化阶段实施：（1）评估与心理教育；（2）生命线构建；（3）人生事件叙事详述；（4）最终阅读与巩固。治疗师在会谈中扮演关键角色，负责引导详细回忆、维持情绪安全感并确保碎片化记忆整合。该过程设计灵活，可适应个体创伤史、文化背景及心理需求。

随机对照试验的实证研究证实，NET在难民、战争幸存者、酷刑受害者、家暴幸存者及自然灾害幸存者等多元群体中均具疗效。研究显示参与者创伤后应激障碍症状、抑郁、焦虑及压力水平显著降低。NET衍生方案如儿童版KIDNET、罪犯版FORNET及在线版e-NET，进一步彰显了该疗法的普适性与可扩展性。这些模式已在非洲难民营、斯里兰卡海啸灾区、东欧政治囚犯群体等多元文化环境中成功实施。

在土耳其，由于自然灾害、移民潮及社会政治因素导致创伤暴露普遍，NET具有巨大应用潜力。尽管疗效确凿，该疗法在土耳其的应用仍受限。针对叙利亚难民的初步研究显示积极成效：创伤后应激障碍、抑郁、焦虑症状显著减轻，自我概念清晰度得到提升。这些发现强调了在土耳其全国临床及社区环境中推进NET研究、文化适应与推广的必要性。

文章最后着重指出，应在土耳其创伤暴露率高且心理健康基础设施薄弱的地区扩大NET应用范围。文章倡导将NET纳入公共卫生体系，培训心理健康专业人员，并制定文化敏感性协议以提升其可及性与有效性。通过这些举措，NET可成为应对创伤心理后遗症、促进受影响人群韧性的重要工具。

关键词: 心理学, 叙事暴露疗法, 创伤后应激障碍, 创伤聚焦干预, 心理咨询。

Структурированное резюме:

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это изнурительное психическое заболевание, возникающее после переживания травмирующих событий и часто приводящее к стойким психологическим и физиологическим симптомам. Традиционные терапевтические подходы, такие как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и терапия длительного воздействия (ПЭ), долгое время считались золотым стандартом лечения ПТСР. Однако в последние годы появилась нарративная

экспозиционная терапия (НЭТ) как многообещающая альтернатива, особенно для людей с сложной историей травм и тех, кто живет в регионах с высоким уровнем травматизма и ограниченным доступом к ресурсам психического здоровья.

НЭТ — это структурированная, краткосрочная и интегративная терапевтическая модель, которая сочетает в себе принципы КБТ, терапии свидетельств, клиентоцентрированной психотерапии и нейротравматологии. Ее основная цель — помочь людям реконструировать свою автобиографическую память, интегрируя травматические переживания в связный жизненный нарратив. Это достигается посредством символического и ритуализированного процесса, включающего построение «линии жизни», где события жизни представлены с помощью физических символов в хронологическом порядке — цветы для положительных переживаний и камни для травматических. Этот метод не только облегчает эмоциональную обработку, но и дает людям возможность вернуть контроль над своей жизненной историей.

Теоретическая основа NET коренится в теории двойного представления памяти, которая постулирует, что травматические воспоминания хранятся в двух отдельных системах: «горячей» памяти (эмоциональные и сенсорные компоненты) и «холодной» памяти (контекстуальные и фактические детали). Травматические переживания часто нарушают интеграцию этих систем, приводя к фрагментированному и навязчивым воспоминаниям. NET направлена на переработку этих воспоминаний путем активации обеих систем в безопасной терапевтической среде, что позволяет уменьшить симптомы ПТСР и восстановить связность повествования. Терапия также опирается на модель эмоциональной переработки, подчеркивая важность привыкания и когнитивной реструктуризации в восстановлении после травмы.

NET реализуется в четыре этапа: (1) оценка и психообразование, (2) построение линии жизни, (3) нарративная проработка жизненных событий и (4) окончательное прочтение и консолидация. Во время этих сессий терапевт играет важную роль в содействии детальному воспоминанию, поддержании эмоциональной безопасности и обеспечении интеграции фрагментированных воспоминаний. Процесс разработан так, чтобы быть гибким и адаптируемым к истории травмы, культурному контексту и психологическим потребностям каждого человека.

Эмпирические данные рандомизированных контролируемых испытаний продемонстрировали эффективность NET среди различных групп населения, включая беженцев, выживших после войны, пыток, домашнего насилия и стихийных бедствий. Исследования показали значительное снижение симптомов ПТСР, депрессии, тревоги и стресса среди участников. Адаптации NET, такие как KIDNET (для детей), FORNET (для правонарушителей) и e-NET (для онлайн-доставки), еще больше подчеркивают универсальность и масштабируемость этого подхода. Эти форматы были успешно применены в различных культурных контекстах, включая африканские поселения беженцев, регионы Шри-Ланки, пострадавшие от цунами, и среди выживших после политического заключения в Восточной Европе.

В контексте Турции, где травматические переживания являются распространенным явлением из-за стихийных бедствий, миграции и социально-политических факторов, NET имеет значительный потенциал. Несмотря на доказанную эффективность, применение NET в Турции остается ограниченным. Предварительные исследования с участием сирийских беженцев показали обнадеживающие результаты, свидетельствующие о снижении уровня ПТСР, депрессии, тревоги и улучшении ясности самооценки. Эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований, культурной адаптации и распространения NET в клинических и общественных учреждениях по всей стране.

В заключение статьи подчеркивается важность расширения использования NET в Турции, особенно в регионах с высоким уровнем травматизации и ограниченной инфраструктурой психического здоровья. В ней отстаивается интеграция NET в системы общественного здравоохранения, обучение специалистов в области психического здоровья и разработка протоколов, учитывающих культурные особенности, для повышения ее доступности и эффективности. Таким образом, NET может служить ценным инструментом в устранении психологических последствий травм и укреплении устойчивости среди пострадавшего населения.

Ключевые слова: психология, нарративная экспозиционная терапия, посттравматическое стрессовое расстройство, интервенции, ориентированные на травму, психологическое консультирование.

संरचित सार

पोस्ट-टॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार है, जो प्रायः आघातपूर्ण घटनाओं के संपर्क में आने के बाद उत्पन्न होता है और लंबे समय तक बने रहने वाले मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक लक्षणों का कारण बनता है। पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) और प्रोलॉन्ड एक्सपोज़र थेरेपी (PE), लंबे समय से PTSD के लिए स्वर्ण-मानक उपचार मानी जाती रही हैं। तथापि, हाल के वर्षों में नैरेटिव एक्सपोज़र थेरेपी (NET) एक प्रभावशाली वैकल्पिक पद्धति के रूप में उभरी है, विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए जिनका आघात इतिहास जटिल रहा है तथा जो उच्च-आघात वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुँच सीमित है।

NET एक संरचित, अल्पकालिक और समन्वित चिकित्सीय मॉडल है, जो CBT, टेस्टिमनी थेरेपी, क्लाइंट-केंद्रित मनोचिकित्सा तथा न्यूरोट्रॉमेटोलॉजी के सिद्धांतों को एकीकृत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को उनकी आत्मकथात्मक स्मृतियों का पुनर्निर्माण करने में सहायता करना है, ताकि आघातपूर्ण अनुभवों को एक संगत जीवन-कथा में समाहित किया जा सके। यह प्रक्रिया “लाइफलाइन” नामक एक प्रतीकात्मक और अनुष्ठानिक पद्धति के माध्यम से संपन्न की जाती है, जिसमें जीवन की घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में भौतिक प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है—सकारात्मक अनुभवों के लिए फूल और आघातपूर्ण अनुभवों के लिए पत्थर। यह विधि न केवल भावनात्मक प्रसंस्करण को सुगम बनाती है, बल्कि व्यक्तियों को अपनी जीवन-कथा पर पुनः नियंत्रण और स्वायत्तता प्राप्त करने में भी सशक्त करती है।

NET का सैद्धांतिक आधार स्मृति की द्वि-प्रतिनिधित्व सिद्धांत (Dual Representation Theory of Memory) में निहित है, जिसके अनुसार आघात संबंधी स्मृतियाँ दो पृथक प्रणालियों में संग्रहीत होती हैं: “हॉट” स्मृति (भावनात्मक और संवेदनात्मक घटक) और “कोल्ड” स्मृति (प्रासंगिक और तथ्यात्मक विवरण)। आघातपूर्ण अनुभव प्रायः इन दोनों प्रणालियों के एकीकरण को बाधित कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्मृतियाँ खंडित और अनैच्छिक रूप से पुनः उभरने लगती हैं। NET का उद्देश्य एक सुरक्षित चिकित्सीय वातावरण में दोनों प्रणालियों को सक्रिय कर इन स्मृतियों का पुनःप्रसंस्करण करना है, जिससे PTSD के लक्षणों में कमी आए और जीवन-कथा की संगति पुनः स्थापित हो। यह थेरेपी भावनात्मक प्रसंस्करण मॉडल (Emotional Processing Model) पर भी आधारित है, जो आघात से उबरने की प्रक्रिया में अभ्यस्तता (habituation) और संज्ञानात्मक पुनर्गठन (cognitive restructuring) के महत्व को रेखांकित करता है।

NET को चार संरचित चरणों के माध्यम से लागू किया जाता है: (1) मूल्यांकन और मनो-शिक्षा, (2) लाइफलाइन का निर्माण, (3) जीवन-घटनाओं का कथात्मक विस्तार, और (4) अंतिम वाचन और समेकन। इन सत्रों के दौरान चिकित्सक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें विस्तृत स्मृति-पुनःस्मरण को सुगम बनाना, भावनात्मक सुरक्षा बनाए रखना, और खंडित स्मृतियों के एकीकरण को सुनिश्चित करना शामिल है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के आघात इतिहास, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार लचीली और अनुकूलनीय रूप से डिज़ाइन की जाती है।

यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षणों (randomized controlled trials) से प्राप्त अनुभवजन्य प्रमाणों ने शरणार्थियों, युद्ध और यातना के पीड़ितों, घरेलू हिंसा से बचे व्यक्तियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों सहित विविध जनसंख्याओं में NET की प्रभावशीलता को सिद्ध किया है। शोधों में प्रतिभागियों के PTSD लक्षणों, अवसाद, चिंता और तनाव में उल्लेखनीय कमी पाई गई है। NET के विभिन्न अनुकूलित रूप, जैसे KIDNET (बच्चों के लिए), FORNET (अपराधियों के लिए), और e-NET (ऑनलाइन माध्यम के लिए), इस पद्धति की बहुपयोगिता और विस्तार-क्षमता को और स्पष्ट करते हैं। इन प्रारूपों का सफलतापूर्वक विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में उपयोग किया गया है, जैसे अफ्रीकी शरणार्थी शिविर, श्रीलंका के सुनामी-पश्चात क्षेत्र, तथा पूर्वी यूरोप में राजनीतिक कारावास से बचे व्यक्तियों के बीच।

तुर्किये के संदर्भ में, जहाँ प्राकृतिक आपदाओं, प्रवास और सामाजिक-राजनीतिक कारकों के कारण आघात का अनुभव व्यापक है, NET अत्यंत संभावनाशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसके सिद्ध प्रभाव के बावजूद, तुर्किये में NET का अनुप्रयोग अभी भी सीमित है। सीरियाई शरणार्थियों पर किए गए प्रारंभिक शोधों ने आशाजनक परिणाम दर्शाए हैं, जिनमें PTSD, अवसाद और चिंता के स्तर में कमी तथा आत्म-धारणा की स्पष्टता में सुधार देखा गया है। ये निष्कर्ष देशभर के नैदानिक और सामुदायिक परिवेश में NET के आगे के अनुसंधान, सांस्कृतिक अनुकूलन और व्यापक प्रसार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

लेख का निष्कर्ष तुर्किये में NET के उपयोग के विस्तार के महत्व पर बल देता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ आघात का स्तर उच्च है और मानसिक स्वास्थ्य अवसरचना सीमित है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में NET के एकीकरण, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण, तथा सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील प्रोटोकॉल विकसित करने की वकालत करता है, ताकि इसकी पहुँच और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके। इस प्रकार, NET आघात के मनोवैज्ञानिक प्रभावों से निपटने तथा प्रभावित समुदायों में लचीलापन (resilience) विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है।

मुख्य शब्द : मनोविज्ञान, नैरेटिव एक्सपोज़र थेरेपी, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आघात-केंद्रित हस्तक्षेप, मनोवैज्ञानिक परामर्श।

Yapılandırılmış Özet:

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), travmatik olaylara maruz kalmanın ardından ortaya çıkan ve genellikle kalıcı psikolojik ve fizyolojik semptomlara yol açan, zayıflatıcı bir ruh sağlığı sorunudur. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Uzun Süreli Maruz Kalma Terapisi (PE) gibi geleneksel terapötik yaklaşımlar, uzun süredir TSSB için altın standart tedaviler olarak kabul edilmektedir. Ancak, son yıllarda, özellikle karmaşık travma geçmişi olan bireyler ve ruh sağlığı kaynaklarına erişimi sınırlı olan yüksek travma bölgelerinde yaşayanlar için umut verici bir alternatif olarak Anlatı Maruz Kalma Terapisi (NET) ortaya çıkmıştır.

NET, CBT, tanıklık terapisi, danışan merkezli psikoterapi ve nörotravmatoloji ilkelerini birleştiren yapılandırılmış, kısa süreli ve bütünleştirici bir terapötik modeldir. Temel amacı, travmatik deneyimleri tutarlı bir yaşam öyküsüne entegre ederek bireylerin otobiyografik hafızalarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmaktır. Bu, yaşam olaylarının kronolojik olarak fiziksel sembollerle temsil edildiği bir “yaşam çizgisi”nin oluşturulmasını içeren sembolik ve ritüelleştirilmiş bir süreçle gerçekleştirilir; olumlu deneyimler için çiçekler, travmatik deneyimler için taşlar kullanılır. Bu yöntem sadece duygusal işlemeyi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin yaşam öyküleri üzerinde kontrolü yeniden ele almalarını sağlar.

NET'in teorik temeli, travmatik anıların iki farklı sistemde depolandığını öne süren Çift Temsil Anı Teorisi'ne dayanmaktadır: “sıcak” anı (duygusal ve duyuşal bileşenler) ve “soğuk” anı (bağlamsal ve olgusal ayrıntılar). Travmatik deneyimler genellikle bu sistemlerin bütünlüğünü bozar ve parçalı ve rahatsız edici anılara yol açar. NET, güvenli bir terapötik ortamda her iki sistemi de aktive ederek bu anıları yeniden işlemek, böylece TSSB semptomlarını azaltmak ve anlatı tutarlılığını yeniden sağlamak amaçlamaktadır. Terapi ayrıca Duygusal İşleme Modelinden yararlanarak travma iyileşmesinde alışma ve bilişsel yeniden yapılandırmanın önemini vurgular.

NET, dört yapılandırılmış aşamada uygulanır: (1) Değerlendirme ve psiko-eğitim, (2) Yaşam çizgisi oluşturma, (3) Yaşam olaylarının anlatımsal detaylandırılması ve (4) Son okuma ve pekiştirme. Bu seanslar sırasında, terapist ayrıntılı hatırlamayı kolaylaştırmak, duygusal güvenliği sağlamak ve parçalanmış anıların bütünleşmesini sağlamak için kritik bir rol oynar. Süreç, kişinin travma geçmişine, kültürel geçmişine ve psikolojik ihtiyaçlarına göre esnek ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

Randomize kontrollü denemelerden elde edilen ampirik kanıtlar, NET'in mülteciler, savaş, işkence, aile içi şiddet ve doğal afetlerden kurtulanlar dahil olmak üzere çeşitli nüfus gruplarında etkinliğini göstermiştir. Çalışmalar, katılımcılar arasında TSSB semptomları, depresyon, anksiyete ve stresin önemli ölçüde azaldığını göstermiştir. KIDNET (çocuklar için), FORNET (suçlular için) ve e-NET (çevrimiçi sunum için) gibi NET uyarlamaları, bu yaklaşımın çok yönlülüğünü ve ölçeklenebilirliğini daha da vurgulamaktadır. Bu formatlar, Afrika'daki mülteci yerleşim yerleri, Sri Lanka'daki tsunami sonrası bölgeler ve Doğu Avrupa'daki siyasi tutuklulardan kurtulanlar dahil olmak üzere çeşitli kültürel bağlamlarda başarıyla uygulanmıştır.

Doğal afetler, göç ve sosyo-politik faktörler nedeniyle travmaya maruz kalmanın yaygın olduğu Türkiye bağlamında, NET önemli bir potansiyele sahiptir. Kanıtlanmış etkinliğine rağmen, NET'in Türkiye'deki uygulaması sınırlı kalmaktadır. Suriyeli mültecileri kapsayan ön araştırmalar, TSSB, depresyon ve anksiyetede azalma ve öz kavram netliğinde iyileşme gibi umut verici sonuçlar göstermiştir. Bu bulgular,

ülke genelinde klinik ve topluluk ortamlarında NET'in daha fazla araştırılması, kültürel uyarlanması ve yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Makale, Türkiye'de, özellikle travmaya maruz kalma oranının yüksek ve ruh sağlığı altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde NET'in kullanımının yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayarak son bulmaktadır. Makale, NET'in erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için kamu sağlık sistemlerine entegrasyonu, ruh sağlığı profesyonellerinin eğitimi ve kültürel açıdan duyarlı protokollerin geliştirilmesini savunmaktadır. Böylelikle NET, travmanın psikolojik sonuçlarını ele almak ve etkilenen nüfuslar arasında dayanıklılığı teşvik etmek için değerli bir araç olarak hizmet edebilir.

Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Anlatı Maruz Kalma Terapisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Travma Odaklı Müdahaleler, Psikolojik Danışmanlık.

www.turkishstudies.net/turkishstudies**Turkish Studies**

eISSN: 1308-2140

**ANKARA SCIENCE
UNIVERSITY**

A New and Holistic Approach to the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder: Narrative Exposure Therapy

Introduction

Individuals exposed to traumatic and stressful life events carry both physical and deep emotional psychological scars caused by these events. These individuals are at risk of developing a range of psychological problems, primarily Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Briere and Scott, 2015). The American Psychiatric Association (APA, 2013) defines PTSD as a set of criteria that emerge after traumatic experiences such as a real threat of death, serious injury, or sexual violence, and include intrusive thoughts reminiscent of the trauma, nightmares, flashbacks, avoidance of stimuli associated with the traumatic experience, and emotional symptoms.

The classification of PTSD has undergone various changes over time. In the most current version used today, DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), (APA, 2013), PTSD is classified under the heading “Trauma and Stress-Related Disorders,” whereas in the previous version, DSM-4, it was classified under the category of “Anxiety Disorders.” Furthermore, DSM-5 emphasizes the need to evaluate symptoms across a broader spectrum by removing subjective emotional responses such as fear, helplessness, and horror, which are not experienced by all individuals with PTSD, from the diagnostic criteria. The definition, meaning, assessment, and presentation of appropriate treatment methods for PTSD have undergone many changes and developments throughout history.

In the past century, important empirical data has been presented on effective methods used in the treatment of PTSD (Foa et al., 2000). Furthermore, the effectiveness of various approaches used in PTSD treatment has been demonstrated in both individual trauma victims (accidents, injuries, life-threatening situations, sexual and physical assault, rape, serious illnesses) and collective trauma victims (refugees, asylum seekers, torture victims, mass killings, etc.). There is strong evidence that these approaches lead to a significant reduction in symptoms and remission among these victims (e.g., Bradley et al., 2003; Nixon et al., 2012; Cowan et al., 2020).

According to assessments conducted by the National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2005), Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapies have been identified as the most effective potential treatment method for PTSD, considering different types of trauma. Similarly, numerous scientific and evidence-based studies have demonstrated that PTSD can be effectively treated with various forms and variants of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and have accepted it as the first-line treatment for PTSD (Cukor et al., 2010, NICE 2005). Prolonged Exposure Therapy (PET), a sub-branch of CBT, is a treatment approach established in 1982 and built on the exposure principle specific to CBT (Foa, 2011). It is considered the “gold standard” in the treatment of PTSD (Foa et al., 2007; Institute of Medicine, 2008). The primary goal of Prolonged Exposure Therapy is

to reduce PTSD symptoms by confronting thoughts, memories, places, activities, and people associated with traumatic experiences “in the here and now” through the technique of “safe confrontation” (Foa et al., 2019).

Additionally, in the treatment of PTSD, the technique recommended by the World Health Organization (WHO, 2013) and developed in 1980 by psychologist Francine Shapiro, “Eye-Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR), is a treatment method whose effectiveness has been proven by numerous scientific studies (e.g., Marcus et al., 1997; Wilson et al., 2018). EMDR aims to help individuals reprocess traumatic memories while encouraging them to focus on stress-inducing elements related to the traumatic memory (images, thoughts, emotions, and physical sensations). This process, through structured eye movements using the “bilateral stimulation” technique, seeks to guide the individual and make the traumatic experience less distressing (Udo et al., 2022). Over the past 30 years, many therapeutic approaches with potential effects on PTSD have been developed; numerous controlled experimental studies have demonstrated that Trauma-Focused CBT and EMDR are effective in the treatment of PTSD (NICE, 2005).

In recent years, Narrative Exposure Therapy (NET), which has gained wide application particularly in Europe and whose effectiveness has been demonstrated in both clinical and non-clinical settings, has been recognized as one of the effective methods for treating PTSD. NET was developed in 2005 by Schauer and colleagues, specifically for refugees living in post-conflict regions who have experienced complex trauma. It is a short-term, standardized method proven effective in treating complex trauma and is a holistic therapy model that builds on the Prolonged Exposure technique of CBT while incorporating principles of Testimony Therapy, Client-Centered Psychotherapy, and Neurotraumatology approaches (Cienfuegos & Monelli, 1983; Foa & Rothbaum, 2001; Crombach & Siehl, 2018). The developers of NET structured the technique around two main principles: (1) Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) and (2) Testimony Therapy. The intervention assumes that recovery occurs in two ways: first, through habituation as in CBT, and second, through the consistent and coherent reconstruction (narration) of traumatic events as in Testimony Therapy (Neuner et al., 2002). Based on these principles, reconstructing life events that cause individual and social stress and evoke emotions such as shame and anger, in a non-judgmental, accepting, active, and empathic therapeutic setting, while restoring autobiographical memory, positions NET as a comprehensive model that also encompasses Client-Centered Psychotherapy and Neurotraumatology approaches (Schauer et al., 2025). Accordingly, the aim of this theoretical article is to explain the theoretical foundations of NET—a trauma-focused approach frequently preferred in clinical research and practice worldwide—evaluate its effectiveness through literature, provide information on its application, and discuss the importance of expanding its use in Türkiye.

Narrative Exposure Therapy: Theoretical Background

One of the theories explaining PTSD, the “dose-response relationship” theory, argues that the frequency and severity of PTSD-related symptoms are proportional to the frequency of traumatic events experienced and the impact they have on the individual (Mollica et al., 1998; 2004). Individuals exposed to complex trauma experience various difficulties in addition to PTSD. These difficulties include problems such as emotional regulation deficits, relationship issues, dissociation, and somatization, which can pose serious threats to the individual’s ability to maintain functioning (Foa et al., 2000; Cloitre et al., 2011). Furthermore, many individuals with PTSD struggle to express their traumatic experiences, while these experiences can be re-lived through sensory elements associated with stress (Brewin, 2014). Based on this, NET is built upon the “Dual Representation” theory of traumatic memory (Brewin et al., 2010; Schauer et al., 2024). According to the Dual Representation theory of traumatic memory, distressing symptoms related to the traumatic event arise from the interaction between autobiographical memory, intrusive thoughts, and Fear Networks.

Autobiographical memory is the type of memory in which places, time, context, content, perceptions, physical sensations, thoughts, and emotions associated with events and experiences are encoded (Tulving, 1972). Fear Networks, as defined by Lang (1977), propose that each new traumatic experience triggers similar memory structures. This model divides memory into two types: Declarative “Cold” Memory and Non-Declarative “Hot” Memory. Declarative Cold Memory encodes contextual information related to life events (such as place, time, and context), while Non-Declarative Hot Memory records sensory, emotional, and physiological information associated with the event (Lang, 1979; Foa & Kozak, 1986).

According to the *Emotional Processing Model* developed by Foa and Kozak (1986), when an individual experiences a traumatic event, sensory information related to the event cannot be functionally processed into the memory system. This leads to sensory, physical, and emotional information associated with the event remaining vivid and intense for a long time, ultimately resulting in the emergence of PTSD symptoms such as intrusive thoughts, isolation, avoidance of trauma-related cues, and flashbacks. More specifically, during traumatic and stressful experiences, the amygdala—the region of the brain responsible for stress responses—shows hyperactivation, which helps shape appropriate stress reactions (Elbert & Schauer, 2002). The amygdala, as part of the limbic system, is also responsible for encoding information related to Non-Declarative “Hot” Memory in autobiographical memory (such as bodily sensations and thoughts associated with the event) (Conway & Fthenaki, 2000). On the other hand, the hippocampus, which works in conjunction with the amygdala, is responsible for encoding information in Declarative “Cold” Memory (such as place, time, and contextual details). Under normal memory processes, these two structures work interactively. However, during a traumatic or stressful experience, the amygdala becomes hyperactive and blocks the functioning of the hippocampus. In this case, the hippocampus cannot process elements of cold memory; instead, due to the excessive activation of the amygdala, elements of hot memory are intensely encoded and stored in the memory system. As a result, when a traumatic event is recalled, the sensations recorded by hot memory are activated, and the individual involuntarily re-experiences the bodily and emotional reactions felt during the event, such as trembling, heart palpitations, crying, and fear. Due to the inability to encode information belonging to cold memory, the individual cannot remember contextual details of the event (such as place, time, and people). This leads to inconsistencies and fragmentation in autobiographical memory related to the traumatic experience, paving the way for the individual to experience PTSD symptoms (Schauer et al., 2024).

Due to this disruption in the structure of autobiographical memory, Foa and Kozak (1986) argued that reactivating fear networks is crucial to enable the healthy integration of information related to the event (elements of hot and cold memory) that were dysfunctionally stored by the amygdala and hippocampus. This integration is necessary for reducing PTSD symptoms and creating a coherent autobiographical narrative. The reprocessing between memory systems occurs through repeated and safe re-experiencing of the traumatic event using the Imaginal Exposure technique. This method reduces avoidance of trauma-related cues and allows fragmented memories of the traumatic experience to be reconstructed in a healthy and coherent manner (Foa et al., 2019).

Based on these theoretical foundations, the aim of the NET technique is to create a coherent and integrated autobiographical memory, thereby enabling the healthy integration of the traumatic experience into the individual’s overall life narrative. For this reason, NET is concerned not only with narrating the worst events experienced but also with recounting significant positive life events (Katsounari, 2015)

Fundamental Principles of Narrative Exposure Therapy

NET is specifically designed for individuals with PTSD who have experienced various types of traumatic life events and adverse experiences. Overall, it is structured around two core principles. One of these principles is the Testimony Therapy technique, which is a fundamental component of the therapeutic process. In NET, this technique aims to “document all of the individual’s experiences in writing and provide this written account to the client at the end of therapy.” This shared product (the written document) created by the therapist and client during therapy allows the individual’s experiences to be heard by others, making the “silent scream” of trauma audible and shareable. Furthermore, in many countries where this technique is widely used, this written document—a copy of the individual’s narrative—is accepted as legal evidence in court. Bearing the signatures of both the client and the therapist, this document also serves as a form of “human rights advocacy” (Schauer et al., 2025). Thus, the therapeutic process fulfills a meaningful purpose not only individually but also socially and politically (Weine et al., 1998; Bichescu et al., 2007). The other component, the Exposure method, uses the “confrontation” technique to reorganize sensory processing related to traumatic experiences and place them into a functional context, aiming to reduce PTSD symptoms. The common goal of both techniques is to reconstruct the individual’s life in a functional and chronological manner, thereby reorganizing autobiographical memory (Schauer et al., 2024).

NET, which is based on the narrative technique, incorporates the universal pattern of “storytelling”—a method considered a shared heritage of humanity and cultures and passed down through generations. Although individuals with PTSD often struggle to articulate their experiences, the sense of relief that occurs after narration and the healing mechanism inherent in the narrative technique are regarded as fundamental components of NET (Schauer et al., 2005).

The inability to integrate traumatic experiences into one’s life story in a healthy way is one of the most common difficulties observed in individuals with PTSD (Brewin, 2014). In NET, all events experienced by the individual (both positive and negative) are addressed one by one and placed into a chronological context from birth to the present. Moreover, the approach emphasizes that, alongside traumatic and adverse experiences, positive experiences also exist, and that the “lost” past is actually part of the individual’s life and should be brought to light. In this way, the individual can view all positive and negative events holistically and draw strength from their experiences. NET, in this respect, is a humanistic approach (Robjant & Fazel, 2010). Additionally, by employing acceptance, empathy, unconditional positive regard, and active listening skills, it also embraces the principles of the Client-Centered Psychotherapy school (Schauer et al., 2024). Therefore, NET is a comprehensive and unique therapeutic technique that integrates principles from Cognitive Behavioral Therapy, Humanistic Psychology, Gestalt Psychology, Narrative Therapy, and Testimony Therapy.

Application and Structure of Narrative Exposure Therapy

Structure of NET

NET is a short-term treatment approach with a flexible session structure. It has been applied across various settings and cultures and has played a significant role in the remission of PTSD (Neuner et al., 2004). Studies have also examined the number and duration of sessions required for effective treatment. Findings indicate that the number of sessions varies depending on factors such as the type and severity of traumatic experiences and the intensity of PTSD symptoms. For example, in an experimental study conducted by Zang and colleagues (2013) with Chinese earthquake survivors, the intervention group received four NET sessions, each lasting 60–90 minutes. Results showed that this brief technique led to significant improvements in PTSD, depression, anxiety, and overall mental health at the two-month follow-up.

The developers of the method, Schauer and colleagues (2024), stated that an average of 10 sessions, each lasting between 90 and 120 minutes and conducted weekly, is suitable for the effectiveness of NET. However, they also emphasized that this may vary depending on the nature of the individual's trauma. For example, when working with refugee groups, at least four sessions are considered necessary, whereas for torture survivors, 8–12 sessions are deemed more appropriate. Additionally, for KIDNET—the child version of NET—it is noted that fewer sessions are effective, considering that a child's life timeline is shorter compared to adults (Schauer, 2005; 2024).

NET: Application

Overview: Theoretically and practically, NET is structured around four main phases:

- 1) Diagnosis–Assessment and Psychoeducation,
- 2) Creating the Lifeline,
- 3) Narrating the Lifeline,
- 4) Re-reading.

Structuring NET sessions in advance (in terms of duration and number of sessions) around these four main phases is highly important. Typically, the first session begins with an assessment of the individual's psychological state and the provision of psychoeducation. After explaining the possible mental state the individual may be experiencing, an explanation about the universality of human rights (for trauma and abuse survivors) is provided, demographic information is collected, medical and psychiatric history is taken, a current status assessment is conducted, and the individual is informed about how the process will proceed.

In the second step, the priority is to establish a comfortable and trust-based relationship with the individual, as they may be reluctant to share life events in detail, and individuals with PTSD may feel confused. This process begins by laying out the lifeline (a thick rope is used) on a flat surface. Chronological information about events is collected without delving deeply into emotional experiences. Individual characteristics and unique circumstances are noted during this stage. The information gathered here is highly important for referencing and addressing later in the session process. After the lifeline is created, each event is processed one by one in chronological order. The individual's narrative is written down in detail after the session (a short version of the session). In the next session, this written narrative is read to the individual, and any omissions or inaccuracies are corrected. Then, the session continues from where it left off. In the final session, the complete written document (covering all sessions) is read aloud to the client. Both the client and the therapist sign the written narrative. A copy of the signed document is given to the client, while another copy may be kept for scientific purposes if needed. Below, detailed information about the structured sessions is provided.

Session 1: Diagnosis, Assessment, and Psychoeducation

Usually during the first session, or in some cases before the first session, the individual's psychiatric history is identified, PTSD and any comorbid disorders are detected (for PTSD, it is generally recommended to use clinician-administered assessment tools such as the PTSD scale/CAPS-5). Then, problem areas are framed, detailed information about the individual is gathered, and treatment goals are established. After diagnosis and assessment, the individual is asked if they have any questions. If they do, these are answered; if not, the session proceeds to psychoeducation.

In psychoeducation, the individual is informed about their current situation, it is emphasized that they are not alone, and their experience is “normalized” (they are told that experiencing such

symptoms as a result of negative life events is normal). Additionally, information is provided about possible symptoms (especially those related to PTSD, such as depression, stress, anxiety, insomnia, lack of enjoyment in life, self-devaluation, feelings of emptiness, and communication/family conflicts).

The intensity and content of psychoeducation should be tailored to the individual's needs. For example, when working with a child, it is more effective to use words that children can understand and are familiar with, and, when necessary, to explain concepts through drawings, toys, or metaphors. In addition, for individuals who may have difficulty using the language—such as refugees—it is very important to use an interpreter or to provide psychoeducation according to the person's educational level (Schauer et al., 2024).

The purpose of psychoeducation is to help the individual understand, explain, and normalize their experiences, and to accept that their current situation is a result of traumatic experiences. In other words, it aims to provide information about dysfunctional emotions, thoughts, and behaviors, raise awareness, normalize reactions (emphasizing that these reactions and behaviors are understandable), and foster realistic acceptance. Therefore, while providing explanations, all questions should be answered without causing confusion. Toward the end of psychoeducation, the process is discussed; explanations are given about the number of sessions, their duration, and structure, and the session is concluded.

Session 2: Creating the Lifeline

After psychoeducation, the second session is dedicated to creating the lifeline. The lifeline is an essential component of NET and has become one of its symbolic elements. This line ritualizes and symbolically represents the person's life story (Schauer et al., 2025). The lifeline is depicted using a rope or ribbon that represents the continuous flow of time. It is usually created by placing a closed ball of yarn—symbolizing the ongoing nature of life—on a flat surface and stretching it out. The lifeline is placed on the ground by the individual, which encourages them to take control of their life during its creation. Then, the individual's birth is marked at the very beginning of the lifeline using a symbol. At this point, symbols that are integral to NET are used. These symbols consist of flowers and stones. Flowers represent positive, happy, and successful moments in the person's life, while stones symbolize painful, negative, and traumatic life events. In some cases, additional symbols such as candles and pieces of wood or twigs may be used. A candle can represent situations such as the death of a loved one or a pet and the associated grief, while a piece of wood or twig can be used to distinguish situations where the person has experienced or perpetrated violence. The developers of NET recommend not diversifying the types of symbols (such as using toys or personal items) and advise that the lifeline should be created within this framework. However, they suggest varying the qualitative characteristics of the flowers, stones, candles, and twigs. For example, larger and darker stones can be used for more traumatic experiences, while large and brightly colored flowers can represent highly joyful life events. This way, life events can be easily distinguished from one another qualitatively.

The symbol chosen to represent the individual's birth is placed at the very beginning of the lifeline. However, if there was a major life event before birth that affected the individual or their family (such as relocation, changes in economic status, the loss of a family member, or illnesses in the family), and the individual considers it important, the lifeline can begin with these events. The individual then places symbols representing all positive and negative experiences in their life from birth to the present, thereby creating the lifeline. When placing symbols on the lifeline, contextual information about the events is gathered without going into too much detail. Information related to location (such as city, home, school, street) and time (year, month, day, season, time of day, or parallel life events) is collected. The individual is asked to label or name these with one or two words. However, since the goal here is not to expose the person to the event, these details are noted next to

the symbols only for later reference and recall. The lifeline ends chronologically with the present time. The individual and therapist then review the gestalt as a whole. At this point, it is important to acknowledge and appreciate the work done (Schauer et al., 2024). Completing this process within a single session and not carrying it over to the next is highly important.

Session 3: Narrating the Lifeline

The next session begins with narrating the first event (symbol) on the lifeline. Since the lifeline usually starts with birth, as much information as possible is gathered about the individual's family and the environment in which they were born. Then, the process continues chronologically by moving to the next symbol. The amount of time spent on each symbol depends on the significance of that event for the individual. However, discussing positive and pleasant events should not exceed 15 minutes, while negative and traumatic experiences should be allocated as much time as necessary. Before talking about the event itself, contextual information should be clearly explained and elaborated:

Time and place: When did the event occur? Life stage, time of year, time of day, a specific moment in the day.

Location and action: Where was the person? Where did the event take place? What was the person doing at that moment? What were they about to do?

Beginning: Detailed information about the start of the event (Schauer et al., 2024).

During the narration of the event (especially a traumatic one), the clinician and the individual switch to "slow-motion mode." The person is asked to visualize the beginning of the event in their mind. From this point onward, the event is processed in detail, step by step. It is important to help the individual understand what they perceived. As many questions as possible are asked about physical sensations, thoughts, behaviors, and details such as the shape, color, smell, and sound of objects, and the individual is encouraged to share this information. This approach reactivates sensory and emotional experiences related to the event, allowing associative memories to surface and cues to be uncovered through reminders. Reality is reinforced. However, the most critical point is to prevent avoidance, dissociation, and flashbacks. While exposure and reliving are desired processes in therapy, dissociation is dangerous and should be avoided. Therefore, it is essential to reinforce the individual's presence with the clinician in the "here and now." After reliving the event, placing it back into the context of the rest of the day and integrating the pieces is important for maintaining the integrity of autobiographical memory (Schauer et al., 2025). For example, if the event occurred in the afternoon, obtaining information about what the person did during the remainder of the day is crucial. During the narration of traumatic and negative experiences, it is important to vividly evoke emotional and sensory memories. The goal of this evocation is to activate sensory, cognitive, emotional, and physiological components related to the event and integrate them. This integration ensures that the activation of one component triggers the activation of others, facilitating the healthy integration of "hot" and "cold" memory. In this way, the autobiographical memory associated with the traumatic experience is reprocessed in a coherent and functional manner. To achieve the integration of hot and cold memory, questions targeting elements of the traumatic experience are exemplified in the NET manual by Schauer and colleagues (2025). Bu çalışma oturumun sonunu getirir. Oturumdan sonraki birkaç günde yaşanılanlar ve anlatılanlar üzerine ciddi düşünme ve içgörü kazanma süreci olabilir. Bu bilişsel yeniden yapılandırma sürecinin doğal bir parçasıdır. Terapist oturumdan sonra hemen bireyin anlattıklarını ve hissettiklerini (oturum sırasında not almalıdır) tüm detayları ile kağıda dökerek onun bakış açısıyla yazmalıdır.

Session 4 and Beyond: Continuing the Narrative

At the beginning of each session, the client should be asked how their week has been, what mood they are in, and what they think and feel about what they have shared so far. This allows for the identification of cognitive changes that may have occurred during the week and the recall of new details related to the reprocessing of autobiographical memory. The individual may also come with new insights about the event. After this, the narrative written down by the therapist in the previous session is read aloud to the client. The client is asked to listen carefully and visualize what is being read. If necessary, changes or corrections are made, and the narration continues with the next symbol on the lifeline. All sessions proceed in this manner until the final session.

Final Session: Rereading the Narrative

Starting from the first narrative session, the entire written document containing the individual's narrative is read aloud to the client. If they wish to make any corrections or additions, these are allowed. One copy is given to the client and one to the therapist, and both sign the document. This joint signature and agreement on the truth of what has been narrated is the core component of Testimony Therapy. However, it should be noted that in some cases, individuals with traumatic experiences (especially survivors of sexual abuse and neglect) may not want to keep a copy of this document and may prefer to leave these painful events behind and start a new chapter in life. In such cases, it is crucial to respect the individual's consent and wishes. As previously mentioned, this written document can serve as legal evidence in Europe and various parts of the world, as it is prepared under the supervision of a clinician for the purpose of human rights advocacy. Following a successful intervention, the individual becomes someone who can think more functionally, socialize, evaluate new opportunities, has increased self-acceptance and awareness, knows their strengths, experiences reduced guilt and reluctance, has greater motivation toward life, and develops a belief in a safe world (Schauer et al., 2005; Mørkved et al., 2014; Schauer et al., 2025).

The Role of the Therapist in Narrative Exposure Therapy

In the NET technique, the individual is encouraged to narrate events in as much detail as possible, particularly to ensure the integration of sensory and contextual information. This allows the person to re-experience the sensory, cognitive, and emotional components of the memories (Mørkved et al., 2014). This is because, for the healthy integration and chronological flow of autobiographical memory, two core principles of NET are essential: helping the individual relive the event (exposure) and reinforcing their sense of safety in the here and now (habituation). Considering that individuals with PTSD often have distorted perceptions of themselves and the world, along with reduced functionality in daily life, the therapist carries significant responsibilities stemming both from the sensitivity of the NET technique and the nature of trauma (Robjant & Fazel, 2010).

Fundamentally, respect must be shown to the individual and their experiences throughout the narrative. This respect and acceptance should be combined with empathy and verbally reflected when necessary. However, two important points must be considered. Firstly, if there are inconsistencies in the individual's narration during therapy, these should be gently and appropriately addressed using proper interviewing skills—even though it represents the person's reality. Secondly, while showing acceptance and empathy, the therapist should avoid glorifying or heroizing the individual. Since people with PTSD often have endured extremely difficult life events, therapists may sometimes respond in an overly admiring way. However, this can prevent the individual from later sharing shameful or self-deprecating experiences, as they may fear shattering the "heroic image" perceived by the therapist. It is also important to avoid artificiality and to provide appropriate and measured responses.

Due to the nature of traumatic experiences, it is quite normal for individuals to experience difficulties such as being unable to speak or express themselves verbally (Schauer et al., 2024).

Therefore, the therapist may occasionally use certain encouraging interviewing techniques to help the client express themselves verbally. However, it is still important that the therapist does not interpret or speak on behalf of the individual. The person themselves is the one who truly knows what they have experienced and felt. There should be no judgment regarding what is right or wrong; the individual's own reality should be accepted from their perspective and should not be corrected.

Additionally, individuals with traumatic experiences often express their silence through bodily reactions (such as rubbing their hands, crying, trembling, sweating, rapid breathing, and feeling restless). In such cases, providing feedback about these bodily reactions can both increase the individual's awareness and allow them to feel that the therapist is present, values them, and understands them throughout the process.

Throughout NET sessions, the therapist must ensure they understand what the individual is saying. They should not skip over points they do not understand, but instead clarify confusion by appropriately stating that they need an explanation. For example, a phrase such as "*I didn't quite understand what you said. Could you repeat that?*" (Schauer et al., 2024) helps eliminate confusion and shows the individual that efforts are being made to understand them, which prevents feelings of loneliness.

As mentioned above, narrating traumatic experiences in as much detail as possible is crucial for the functional reintegration of autobiographical memory. Therapists who are new to the NET technique often report difficulty in eliciting detailed accounts (Robjant & Fazel, 2010; Schauer et al., 2011). The key to overcoming this challenge is for the therapist to visualize what the individual is describing as if it were a film, correcting inconsistencies and filling in gaps by asking questions. This approach helps the therapist form a more concrete mental image of the event while simultaneously encouraging the individual to provide a more detailed narrative. In other words, the imagination technique works in a reciprocal manner.

The therapist should avoid behaviors that could harm the narrative process and act honestly and predictably. Especially when working with individuals with PTSD, building and maintaining trust is essential. The therapist should adopt a genuine and warm attitude and provide flexibility when necessary. For example, if the individual wishes to discuss an important event that occurred during the week, they should not be dismissed, and sufficient time should be allocated. However, this should not dominate the entire session. Since NET is a structured technique, the individual should be informed about the process before the session and whenever necessary, ensuring no confusion arises. In some cases, the therapist may express understanding by sharing limited personal information, but this is generally not recommended. During the narrative process, the therapist should avoid talking about themselves (except in very limited cases), making random comments, adopting a didactic attitude, giving advice, and should remain aware of their posture and reactions. For example, they should be careful not to display reactions such as deep sighing, disgust, or laughter (Schauer et al., 2025). Additionally, the therapist should remain predictable in their actions and, if they need to perform any behavior during the session (such as adjusting a chair, drawing a curtain, or closing a door), they should explain this to the individual beforehand.

As with other therapeutic processes, NET is subject to the highest standards of confidentiality and commitment between the individual and the therapist. Therefore, it is essential to provide assurance and emphasize that no information will be shared with third parties without the individual's consent. Since this process is built on principles of trust and confidentiality, the individual's voluntary participation is fundamental. Although individuals with PTSD may fear that their experiences will not be understood or cannot be expressed, they should be encouraged to share their narrative. On the other hand, if the individual does not wish to talk about their experiences, the therapist must always respect their boundaries, avoid overwhelming them, and never pressure them

to disclose. However, the therapist should also inform the individual about possible consequences and responsibilities (Schauer et al., 2024).

Different Forms of Narrative Exposure Therapy

Although the NET technique was originally developed for the treatment of PTSD in adult refugee populations, over time it has been applied to different populations and various adaptation studies have been conducted.

The version of NET developed for children and adolescents is called **KIDNET**. The first studies were based on clinical trials conducted with outpatient child patients at the University of Konstanz and research with displaced children in Sri Lanka. The results of these studies demonstrated that KIDNET is particularly effective for children who have been displaced or are victims of organized crime (Schauer et al., 2004; Onyut et al., 2005). Unlike adults, building trust is even more critical in KIDNET. The goal is to restore emotional connection through therapeutic interaction while addressing attachment issues caused by traumatic experiences.

To establish this trust, visual materials such as drawings and figures may be used during lifeline creation or narration. Creativity and play can be highly beneficial for helping children elaborate their narratives. In this context, Schauer et al. (2024) emphasize that creating the lifeline is of critical importance in KIDNET. The creativity involved in this process can help children overcome barriers and express themselves more comfortably. Compared to adults, children's lifelines may be shorter depending on age; however, in some cases, they can be nearly as long as an adult's. Additionally, in KIDNET, the lifeline can be enriched with symbols representing not only the past but also the future. For example, life events such as "When I finish school" or "When I get married" can be placed on the lifeline using appropriate symbols (Schauer et al., 2024).

The version of NET for offenders is called **FORNET**. In addition to the core principles and components of NET, FORNET focuses on "the perpetration of violence." Its aim is to help offenders gain control over violent behaviors (Crombach et al., 2015).

Alongside KIDNET and FORNET, in response to the restrictions brought by the COVID-19 pandemic, Kaltenbach and colleagues (2021) developed the online version of NET, known as **e-NET**, and published a manual for its implementation. NET also has versions tailored for trauma-affected older adults (**ElderNET**) and for communities exposed to collective trauma (such as villages, ethnic groups, or families), where individual trauma narratives are processed within a group setting—this version is called **NETfacts** (Schauer et al., 2025).

The Effectiveness of Narrative Exposure Therapy in Treating PTSD and Comorbid Disorders

NET was originally designed and implemented by Schauer and colleagues (2005) to treat psychological problems among refugee populations living in post-conflict regions. As a short-term and effective therapeutic technique, it was rapidly adopted worldwide and its research scope has expanded significantly.

The first experimental study investigating the effectiveness of NET was conducted by Neuner and colleagues (2004) with 43 Sudanese refugees settled in Uganda. This study, carried out between 2000 and 2001, involved 43 Sudanese refugees who had fled the civil war and settled in northern Uganda. Participants were randomly assigned to three groups: The first group (N = 12) received only one session of psychoeducation. The second group (N = 14) received psychoeducation plus three sessions of Supportive Counseling. The third group received psychoeducation plus three sessions of NET. The researchers conducted the study with the help of local interpreters and collected data at four different time points. Pre-test, post-test, and follow-up assessments at 4 months and 1 year revealed significant differences between the groups. The group that received NET showed a

substantial reduction in PTSD symptoms, and this improvement remained in remission even one year later.

The second experimental study was conducted by Bichescu and colleagues (2007). The researchers carried out a randomized controlled trial with two groups: NET and Psychoeducation, working with 18 Romanian former political prisoners. The first group (control group) received only one session of psychoeducation, while the second group (experimental group) received NET. Pre-test and post-test measurements showed that participants in the experimental group had significantly greater reductions in PTSD and depression levels compared to the control group. Follow-up assessments conducted six months after the study revealed that PTSD and depression levels remained lower in the NET group compared to the psychoeducation group; 56% of participants in the NET group showed a reduction in PTSD symptoms, whereas this rate was only 11% in the control group.

As explained above, experimental studies have been conducted to evaluate the effectiveness of NET; it has been compared with other psychological interventions such as psychoeducation, supportive counseling, group therapy, stress inoculation training, meditation and relaxation, and present-focused therapy, and the superiority of NET in treating PTSD has been demonstrated (Neuner et al., 2004; Bichescu et al., 2007; Neuner et al., 2008; Catani et al., 2009; Schaal et al., 2009; Neuner et al., 2010; Ruf et al., 2010; Hensel-Dittmann et al., 2011; Lely et al., 2019). Orang and colleagues (2018), in their study with Iranian women exposed to intimate partner violence, found that the NET technique had a significant effect in reducing depression and perceived stress. Furthermore, Zang and colleagues (2013) evaluated the effectiveness of the short form of NET (4 sessions) with survivors of the Sichuan earthquake, which occurred in China in 2008 and caused massive destruction, and revealed that it was effective in reducing symptoms of PTSD, depression, and anxiety. In addition, the effectiveness of NET has been demonstrated not only in the treatment of PTSD but also in the treatment of various psychological disorders associated with PTSD and across different populations. For example, other studies in the literature have confirmed the effectiveness of NET in treating borderline personality disorder accompanied by PTSD, sleep problems, and suicidal ideation (Stenmark et al., 2013; Halvorsen et al., 2014; Pabst et al., 2014; Steuwe et al., 2016; Weinhold et al., 2017).

Considering all these findings, NET, which is designed to alleviate PTSD symptoms in refugee populations, has also been shown to be effective in the treatment of PTSD and comorbid disorders, and its applicability for addressing complex trauma across different populations has been demonstrated in various studies. Moreover, experimental research has revealed that even its short form is effective in situations requiring urgent intervention, such as natural disasters.

Conclusion and Recommendations

Studies in the literature emphasize that many psychological intervention methods are particularly suitable for Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic societies, yet they may fall short or prove inappropriate when it comes to universal applications (Kleinman & Benson, 2006; Henrich et al., 2010; Li et al., 2023). Therefore, developing techniques that are universally applicable and highly effective, and implementing them in clinical practice, is of critical importance.

The core strength of NET lies in its ability to work through a chronological lifeline with individuals who have multiple trauma histories, integrating both traumatic and positive memories. This approach is particularly helpful for refugees, war survivors, or individuals with a history of childhood abuse, as it aids in making sense of the place of trauma within their life narrative (Lely et al., 2019). However, it is important to acknowledge certain limitations of NET. First, since the method requires an intensive narrative process, its application can be challenging for individuals with severe dissociative symptoms or those who experience excessive emotional activation during

narration. Therefore, using an assessment tool to measure dissociative symptoms during the initial psychoeducation and evaluation phase, and proceeding with these considerations in mind, may be beneficial. Moreover, the effectiveness of NET largely depends on the therapist's ability to structure the narrative and maintain cultural sensitivity, making multicultural competence indispensable in diverse cultural contexts. Among practical challenges are the intense emotional reactions that may arise during the detailed recall of traumatic memories and the need to preserve the therapeutic alliance throughout the process. This requires a high level of psychological resilience for both the client and the therapist. Additionally, although NET is generally designed as a short-term protocol, the number of sessions inevitably increases in cases of multiple trauma histories, which may create limitations in terms of time and resources.

Among the advantages of NET compared to other trauma-focused therapies are its effectiveness in cases of multiple trauma histories and its ability to strengthen the sense of identity by integrating the life narrative. While methods such as EMDR or Prolonged Exposure Therapy typically focus on single traumatic memories, NET offers a broader perspective. However, as a disadvantage, NET does not demonstrate as rapid symptom reduction as structured exposure techniques, and some studies have reported lower effectiveness compared to EMDR (Watts et al., 2013).

On the other hand, the fact that NET incorporates many elements that are universal and rooted in shared cultural practices—such as autobiographical narration and storytelling—demonstrates its potential for effective use in the treatment of PTSD. This technique, which has a broad range of applications worldwide, is recognized and recommended by leading mental health organizations such as the APA as an evidence-based treatment for PTSD (APA, 2017). However, NET has not yet been fully explored in Turkey, and research in this area remains limited. One existing study in the literature focused on the effectiveness of NET on variables such as PTSD, depression, anxiety, stress, and self-concept clarity among Syrian refugees in Turkey (Aysazcı Çakar, 2024). The findings of this study indicate that NET offers promising results in reducing symptoms of PTSD, depression, anxiety, and stress among Syrian refugees and provides significant positive changes in terms of self-concept clarity. At this point, it is important to ensure that the language used during psychoeducation and narrative sessions is adapted to the individual's educational level and cultural expressions to facilitate its application in the Turkish context. Given the high diversity and potential for traumatic experiences in our country—stemming from both human-made and natural disasters—NET protocols can be adapted for commonly encountered traumatic situations such as earthquakes, migration, and domestic violence. Furthermore, the short form of NET (4-session NET) can be utilized in post-disaster field interventions.

In light of all these considerations, the diversity of societal and individual traumatic experiences in our country, the limited availability of appropriate intervention techniques, the shortcomings of existing therapy methods, their inadequacy in emergency disaster or crisis situations, and the constraints in accessibility due to time and resources highlight the critical importance of expanding the application of NET in Turkey. Accordingly, it is essential to diversify research in this field and conduct adaptation studies, as well as to demonstrate the effectiveness of the technique through robust and varied research designs. It is evident that this approach can make significant contributions to improving and strengthening the mental health of individuals at risk and reintegrating them into society, both in clinical settings and in public institutions serving the community. Therefore, to promote the widespread use of NET in Turkey, Turkish-language training materials and supervision programs should be developed for psychologists and psychiatrists. Future academic studies should prioritize experimental research—similar to those conducted in Europe and other regions of the world—to investigate the effectiveness of NET in Turkey, thereby enabling the

integration of this innovative, holistic, practical, and valuable approach into the treatment of PTSD and comorbid disorders in our country.

www.turkishstudies.net/turkishstudies**Turkish Studies**

eISSN: 1308-2140

**ANKARA SCIENCE
UNIVERSITY**

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Tedavisinde Yeni ve Bütüncül bir Yaklaşım: Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi

Giriş

Travmatik ve stres yaratan yaşam olaylarına maruz kalan bireyler, bu olayların yarattığı hem fiziksel hem de duygusal derin psikolojik izleri taşırlar. Bu bireyler, başta Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) olmak üzere, bir dizi psikolojik sorunla karşı karşıya kalma riski taşırlar (Briere ve Scott, 2015). Amerikan Psikiyatri Birliği (APA, 2013) TSSB'yi; gerçek ölüm tehdidi, ciddi yaralanma ya da cinsel şiddet gibi travmatik yaşantıların ardından ortaya çıkan, travmayı anımsatan araya girici düşünceler, kabuslar, flaşbekler, travmatik yaşantı ile ilişkili uyaranlardan kaçınma, duygusal belirtileri kapsayan bir dizi kriter kümesi ile tanımlamaktadır.

TSSB'nin sınıflandırılması, zaman içinde çeşitli değişiklikler göstermiştir. Bugün kullanılan en güncel versiyon olan DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El kitabı) (APA, 2013)'te TSSB, 'Travma ve Stresle İlişkili Bozukluklar' başlığı altında yer alırken, önceki versiyon olan DSM-4 'te 'Anksiyete Bozuklukları' kategorisinde sınıflandırılmıştır. Ayrıca DSM-5, tüm TSSB'li bireylerde deneyimlenmeyen korku, çaresizlik ve dehşet gibi subjektif duygusal tepkileri tanısal kriterlerden çıkararak, semptomların daha geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. TSSB'nin tanımı, anlamı, değerlendirilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin sunulması tarihsel süreçte pek çok değişim ve gelişime uğramıştır.

Geçtiğimiz yüzyılda TSSB'nin tedavisinde kullanılan etkili yöntemlerle ilgili önemli ampirik veriler ortaya konmuştur (Foa vd., 2000). Ayrıca, TSSB tedavisinde kullanılan çeşitli yaklaşımların etkinliği, hem bireysel travma mağdurları (kaza, yaralanma, ölüm tehlikesi, cinsel ve fiziksel saldırı, tecavüz, ciddi hastalıklar) hem de kolektif travma mağdurları (mülteciler, sığınmacılar, işkence mağdurları, toplu katliamlar gibi) üzerinde kanıtlanmıştır. Bu mağdurların semptomlarında belirgin bir azalma ve remisyon sağladığına dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır (örn., Bradley vd., 2003, Nixon vd., 2012, Cowan vd., 2020).

Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2005) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapiler, farklı travma türleri göz önünde bulundurulduğunda, TSSB'nin tedavisinde en etkili potansiyel tedavi yöntemi olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde, birçok bilimsel ve kanıta dayalı çalışma, TSSB'nin Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yönteminin çeşitli formları ve varyantlarıyla etkili bir şekilde tedavi edilebileceğini ortaya koymuş ve TSSB tedavisinde ilk basamak tedavi (first-line treatment) olarak kabul etmiştir (Cukor vd., 2010, NICE 2005). BDT'nin bir alt dalı olan Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisi (Prolonged Exposure Therapy)'nin, 1982 yılında temelleri atılmış ve BDT'ye özgü maruz bırakma ilkesi üzerine inşa edilmiş bir tedavi yaklaşımıdır (Foa, 2011). TSSB'nin tedavisinde "altın standart" (gold standard) olarak kabul

edilmektedir (Foa vd., 2007; Institute of Medicine, 2008). Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisi'nin temel amacı; travmatik yaşantılarla ilişkilendirilen düşünceler, anılar, mekanlar, aktiviteler ve insanlarla "güvenli yüzleştirme" (safe confrontation) tekniği aracılığıyla "şimdi ve burada" karşılaşarak TSSB semptomlarını azaltmaktır (Foa vd., 2019).

Ayrıca, TSSB tedavisinde özellikle Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation [WHO], 2013) tarafından tavsiye edilen ve 1980 yılında Psikolog Francine Shapiro tarafından geliştirilen "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing - EMDR) tekniği, pek çok bilimsel çalışma ile etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir (Örn: Marcus vd., 1997; Wilson vd., 2018). EMDR, bireylerin travmatik anılarını yeniden işlemelerine yardımcı olmayı hedeflerken, aynı zamanda bireylerin travmatik anıya ilişkin stres verici unsurlara (görüntüler, düşünceler, duygular ve fiziksel duyular) odaklanmalarını teşvik eder. Bu süreç, "ikili uyarım" (bilateral stimulation) tekniği ile yapılandırılmış göz hareketleri aracılığıyla, bireyi yönlendirerek travmatik yaşantıyı daha az acı verici hale getirmeyi amaçlar (Udo vd., 2022). Geçtiğimiz son 30 yılda, TSSB'nin tedavisinde potansiyel etkiye sahip olan pek çok tedavi yaklaşımı geliştirilmiş; yapılan pek çok kontrollü deneysel çalışma ile Travma Odaklı BDT ve EMDR'ın TSSB tedavisinde etkili olduğunu kanıtlamıştır (NICE, 2005).

Son yıllarda ise özellikle Avrupa'da geniş bir kullanım alanı kazanan ve etkiliği hem klinik hem de klinik olmayan ortamlarda kanıtlanmış olan Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi (Narrative Exposure Therapy - NET), TSSB tedavisinde etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmiştir. NET, 2005 yılında Schauer ve arkadaşları tarafından, özellikle çatışma sonrası bölgelerde yaşayan ve kompleks travma deneyimleri olan mültecilere yönelik olarak geliştirilmiş bir tekniktir. Kısa süreli, standardize edilmiş ve özellikle kompleks travmanın tedavisinde etkililiğini kanıtlanmış bir yöntem olup BDT yaklaşımının Uzun Süreli Maruz Bırakma Tekniği'ni temel alarak Şahitlik Terapisi, Danışan Merkezli Psikoterapi ile Nörotravmatoloji yaklaşımlarının ilkelerini de içeren bütüncül bir terapi modelidir (Cienfuegos & Monelli, 1983; Foa & Rothbaum, 2001; Crombach & Siehl, 2018). NET'in geliştiricileri, tekniği temel olarak iki ana ilke üzerinde şekillendirmiştir: 1) Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi (TO-BDT) ve 2) Şahitlik Terapisi. NET müdahalesinde iyileşmenin iki farklı biçimde gerçekleştiği hipotezi öne sürülmektedir. İlkinde, BDT'de olduğu gibi, habitüasyon süreciyle bir iyileşme sağlanırken ikincisinde ise Şahitlik Terapisi'nde olduğu gibi yaşanan travmatik olayların tutarlı ve uyumlu bir biçimde yeniden yapılandırılması (anlatıma dökülmesi) söz konusudur (Neuner vd., 2002). Bu ilkeler doğrultusunda, bireysel ve sosyal olarak stres yaratan, utanç ve kızgınlık gibi duygulara yol açan yaşam olaylarının; yargılayıcı olmayan, kabul edici, aktif ve empatik dinleme teknikleriyle bir terapist eşliğinde yeniden yapılandırılması, aynı zamanda otobiyografik belleğin işlevsel hale getirilmesi, bu tekniği Danışan Merkezli Psikoterapi ve Nörotravmatoloji yaklaşımlarını da kapsayan bütüncül bir model olarak konumlanmasına olanak tanımaktadır (Schauer vd., 2025). Bu bilgilerden hareketle, bu kuramsal makalenin amacı dünyanın pek çok ülkesinde klinik araştırma ve uygulamalarda sık sık tercih edilen travma odaklı bir yaklaşım olan NET'in teorik temellerinin açıklanmak, literatürdeki çalışmalarla etkililiğinin değerlendirilmek, tekniğin uygulanması hakkında bilgi vermek ve Türkiye'de kullanımının yaygınlaştırılmasının önemini açıklamak ve tartışmaktır.

Anlatısal Maruz Bırakma Terapisi: Teorik Arka Plan

TSSB'yi açıklayan kuramlardan biri olan "Doz-Yanıt ilişkisi" (dose-response relationship) kuramı, TSSB ile ilişkili semptomların sıklığı ve şiddetinin, yaşanan travmatik olayların sıklığı ve birey üzerinde bıraktığı etkiyle orantılı olduğunu savunmaktadır (Mollica vd., 1998; 2004). Kompleks travmaya maruz kalan bireyler, TSSB'ye ek olarak, travmatik deneyimlerle ilişkili çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Bu zorluklar arasında duygusal düzenleme güçlükleri, ilişkilerde problemler,

dissosiyasyon ve somatizasyon gibi durumlar yer alır ve bu olumsuz deneyimler bireyin işlevselliğini sürdürmesinde ciddi tehditler oluşturabilir (Foa vd., 2000; Cloitre vd., 2011). Ayrıca, pek çok TSSB'li birey travmatik yaşantılarını ifade etmekte zorlanırken, öte yandan bu yaşantılar stresle ilişkili duyuşal unsurlar üzerinden yeniden deneyimlenebilmektedir (Brewin, 2014). Bu noktadan hareketle, NET travmatik “Belleğin İkili Temsili” (Dual-Representation) teorisi üzerine inşa edilmiştir (Brewin vd., 2010; Schauer vd., 2024). Travmatik Belleğin İkili Temsil teorisine göre, travma anına ilişkin rahatsız edici semptomlar; otobiyografik bellek, araya giren düşünceler ve Korku Ağlarının (Fear Network) etkileşiminden kaynaklanmaktadır. *Otobiyografik bellek*; olaylarla ve anılarla ilişkilendirilen yer, zaman, bağlam, içerik, algılar, fiziksel duyumlar, düşünceler ve duyguların kodlandığı bellek türüdür (Tulving, 1972). Lang (1977) tarafından tanımlan Korku Ağları ise; her yeni travmatik yaşantının, benzer bellek yapılarını tetiklediği savunmaktadır. Bu model, belleği Deklaratif Soğuk Bellek (Declarative ‘Cold’ Memory) ve Deklaratif Olmayan Sıcak Bellek (Non-Declarative ‘Hot’ Memory) olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Deklaratif Soğuk Bellek, yaşam olaylarıyla ilişkili bağlamsal bilgileri (yer, zaman, bağlam gibi) kodlarken, Deklaratif Olmayan Sıcak Bellek, olayla ilişkili duyuşal, duygusal ve fizyolojik bilgileri kaydetmektedir (Lang ,1979; Foa & Kozak 1986).

Foa ve Kozak (1986) tarafından geliştirilen bilginin *Duygusal İşleme Modeli* (Emotional Processing Model)’ne göre, birey travmatik bir yaşantı deneyimlediğinde, olayla ilişkili duyuşal bilgiler işlevsel bir şekilde bellek sistemine işlenemez. Bu durum olayla ilişkili duyuşal, fiziksel ve duygusal bilgilerin uzun süre boyunca canlı ve güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesine, sonuç olarak TSSB semptomlarının (araya giren düşünceler, izolasyon, olayı hatırlatan uyaranlardan kaçınma ve flaşbekler gibi) ortaya çıkmasına neden olur. Daha detaylı bir şekilde şöyle açıklanabilir; travmatik ve stresli yaşantılar sırasında amigdala, beynimizdeki stres tepkilerinden sorumlu bölge olarak aşırı aktivasyon gösterir ve bu durum uygun stres tepkilerini şekillendirmeye yardımcı olur (Elbert & Schauer, 2002). Limbik sistemin bir parçası olan amigdala, aynı zamanda otobiyografik belleğimizdeki Deklaratif Olmayan Sıcak Bellek ile ilişkili bilgilerin (olayla ilişkili bedensel duyumlar ve düşünceler gibi) kodlanmasından da sorumludur (Conway & Fthenaki, 2000). Öte yandan, amigdala ile birlikte çalışan hipokampus ise Deklaratif Soğuk Bellek’teki bilgilerin (yer, zaman ve bağlamsal bilgiler gibi) kodlanmasından sorumludur. Normal bellek süreçlerinde bu iki yapı etkileşim halinde çalışır. Ancak travmatik veya stresli bir deneyim sırasında amigdala aşırı aktivasyon göstererek hipokampus'un işlevini bloke eder. Bu durumda, hipokampus olayla ilgili soğuk belleğin öğelerini işleyemez, aksine amigdala aşırı aktivasyon nedeniyle sıcak belleğin öğelerini aşırı biçimde kodlayarak bellek sistemine depolar. Sonuç olarak, travmatik bir olay hatırlanmaya çalışıldığında, sıcak belleğin kaydettiği duyumlar devreye girer ve birey olay anında yaşadığı bedensel ve duygusal tepkileri yeniden deneyimleyerek; titreme, kalp çarpıntısı, ağlama ve korku gibi tepkileri istemsiz şekilde ortaya koyar. Soğuk belleğe ait bilgilerin kaydedilememesi nedeniyle, birey olayın bağlamsal bilgilerini (yer, zaman, kişiler gibi) hatırlayamaz. Bu durum da travmatik yaşantıya ait otobiyografik bellekte tutarsızlıklar ve parçalanmalar oluşturarak bireyin TSSB semptomlarını deneyimlemesine zemin hazırlar (Schauer vd., 2024).

Otobiyografik belleğin yapısında meydana gelen bu bozulma nedeniyle; Foa ve Kozak (1986) korku ağlarının yeniden aktif hale getirilmesinin önemli olduğunu, böylece amigdala ve hipokampusun işlevsiz bir biçimde depoladığı olayla ilgili bilgilerin (sıcak ve soğuk belleğin) sağlıklı bir şekilde entegrasyonunun sağlanmasının TSSB semptomlarının azaltılması ve tutarlı bir otobiyografik anlatının oluşturulması için gerekli olduğunu savunmuştur. Bellek sistemleri arasındaki bu yeniden işleme süreci, İmajinasyonel Maruz Bırakma tekniği kullanılarak travmatik yaşantının defalarca ve güvenli bir ortamda yeniden deneyimlenmesiyle gerçekleşecektir. Bu yöntem, bireyin travmatik yaşantının hatırlatıcılarından kaçınmasını azaltacak ve travmatik yaşantıya ilişkin kopuk anıların sağlıklı ve tutarlı bir biçimde yeniden oluşturulmasını sağlayacaktır (Foa vd., 2019).

Bu kuramsal temellerden hareketle; NET tekniğinin amacı; uyumlu ve bütünsel bir otobiyografik bellek oluşturarak travmatik yaşantıyı bireyin tüm yaşantısal anlatısına sağlıklı bir şekilde entegre etmektir. Bu sebeple; NET yalnızca yaşanan en kötü olaylarla değil, aynı zamanda bireyin hayatındaki önemli pozitif yaşam olaylarının anlatımıyla da ilgilenmektedir (Katsounari, 2015).

Anlatısal Maruz Bırakma Terapisinin Temel İlkeleri

NET özellikle farklı türde travmatik yaşam olayı ve olumsuz deneyime sahip olan TSSB'li bireylerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Genel olarak, iki temel prensip etrafında şekillenmiştir. Bu prensiplerden biri, terapi sürecinin temel bileşenlerinden olan Şahitlik Terapisi tekniğidir. Bu teknik ile NET'te "bireyin tüm yaşadıklarının yazıya dökülmesi ve terapinin sonunda danışana verilmesi" amaçlanır. Terapist ve danışanın terapi sürecinde elde edilen bu ortak ürünü (yazılı belge), Bireyin yaşadıklarının başkaları tarafından duyulmasına olanak sağlayarak, travmanın getirdiği "sessiz çılgınlık" duyulabilir ve paylaşılabılır olmasına aracı olur. Ayrıca, bireyin anlattıklarının ve yaşadıklarının yazılı bir kopyasına olan bu döküman, bu tekniğin yaygın olarak kullanıldığı birçok ülkede yasal sistemler tarafından mahkemede delil olarak kabul edilmektedir. Hem bireyin hem de terapistin imzasını taşıyan bu belge, başka bir deyişle, "insan hakları savunuculuğu"nu da üstlenmektedir (Schauer vd., 2025). Dolayısıyla, terapi süreci; bireysel, sosyal ve politik açıdan da anlamlı bir amaca hizmet etmektedir (Weine vd., 1998; Bichescu vd., 2007). Diğer bir bileşen olan Maruz Bırakma yöntemi ise, "yüzleştirme" (confrontation) tekniğini kullanarak, travmatik yaşantılarla ilgili duygusal işlemleri yeniden düzenleyip fonksiyonel bir bağlama oturarak TSSB semptomlarını azaltmayı hedefler. Her iki tekniğin ortak amacı, bireyin yaşantısının işlevsel ve kronolojik bir biçimde yeniden yapılandırılmasını sağlayarak otobiyografik belleğin yeniden düzenlenmesidir (Schauer vd., 2024).

Anlatı tekniğine dayanan NET, aslında bütün insanlığın ve kültürlerin ortak mirası kabul edilen ve nesillerden nesillere aktarılan evrensel bir örüntü olan "hikaye anlatımı" yöntemini bünyesinde barındırmaktadır. Her ne kadar TSSB'li bireyler yaşadıklarını anlatabilme noktasında zorluklar çekseler de, anlatım gerçekleştikten sonra meydana gelen rahatlama ve anlatı tekniğinin temel mekanizması olan iyileştirici unsur, NET tekniğinin de temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilmektedir (Schauer vd., 2005).

Travmatik deneyimleri yaşam öyküsüne sağlıklı bir biçimde yerleştirememeye, TSSB'li bireylerde görülen ve en sık karşılaşılan durumdur (Brewin, 2014). NET'te, bireyin yaşadığı tüm olaylar (olumlu ve olumsuz) doğumdan şimdiki zamana kadar tek tek ele alınarak kronolojik bağlama oturtulmaya çalışılır. Ayrıca, bireyin yaşamında deneyimlediği travmatik ve olumsuz yaşantıların yanı sıra olumlu deneyimlerin de olduğu, "kaybolmuş" geçmişin aslında bireyin yaşantısının bir parçası olduğu ve gün yüzüne çıkarılması gerektiği düşüncesiyle ilerlenir. Böylece, birey yaşadığı olumlu ve olumsuz tüm olayları bütüncül bir şekilde görerek yaşadıklarından güç alır. NET bu yönüyle hümanistik bir yaklaşımdır (Robjant & Fazel, 2010). Ayrıca; kabul edici, empatik, koşulsuz kabul ve aktif dinleme becerilerini kullanarak, aynı zamanda Danışan Merkezli Psikoterapi ekolünün ilkelerini de benimsemektedir (Schauer vd., 2024). Dolayısıyla, NET; Bilişsel Davranışçı Terapi, Hümanistik Psikoloji, Gestalt Psikolojisi, Öyküsel Terapi ve Şahitlik Terapisi gibi çeşitli Psikoterapi tekniklerinin ilkeleriyle çalışan bütüncül ve özgün bir terapi tekniğidir.

Anlatısal Maruz Bırakma Terapisinin Uygulanması ve Yapısı

NET'in yapısı

NET, esnek bir oturum yapısına sahip kısa süreli bir tedavi yaklaşımıdır. Pek çok farklı alan ve kültürde uygulanmış ve özellikle TSSB'nin remisyonunda önemli bir rol oynamıştır (Neuner vd. 2004). Yapılan çalışmalar, paralel olarak uygun ve başarılı bir tedavi için gerekli olan seans sayısı

ve süresini de test etmiştir. Sonuçlar, seans sayılarının travmatik yaşantı tarzına, şiddetine ve TSSB semptomlarının şiddeti gibi pek çok duruma bağlı olarak değişeceğini ortaya koymuştur. Örneğin, Zang ve meslektaşları (2013)'nın Çinli depremzedelerle yaptıkları deneysel bir çalışmada, deney grubuna her biri 60-90 dakika arasında süren 4 oturumluk NET uygulanmış ve sonuçlar kısa süreli bu tekniğin 2 aylık izlem ölçümlerinde; TSSB, depresyon, anksiyete ve genel ruh sağlığında anlamlı iyileşmeler olduğunu göstermiştir.

Kuramın geliştiricileri Schauer ve meslektaşları (2024), her biri 90-120 dakika arasında olan ve haftada bir şeklinde ilerleyen ortalama 10 oturumun NET'in etkililiği için uygun olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, yine altı çizilen diğer bir nokta, bu durumun bazen bireyin travma doğasına göre değişebileceğidir. Örneğin, mülteci grubu ile çalışıldığında en az 4 oturumun gerekli olduğu vurgulanırken işkence mağdurları için 8-12 oturumun daha uygun olacağı belirtilmektedir. Ayrıca, NET'in çocuk formu olan KIDNET'in de çocuğun yaşam çizgisinin yetişkinlere göre daha kısa olacağı göz önünde bulundurularak daha az sayıda oturumla etkili olacağı ifade edilmiştir (Schauer, 2005; 2024)

NET: Uygulama

Genel Bakış: NET, kuramsal olarak ve uygulamada dört temel evre etrafında yapılandırılmıştır:

- 1) Tanı-Değerlendirme ve Psikoeğitim,
- 2) Yaşam Çizgisi Oluşturma,
- 3) Yaşam Çizgisinin Anlatımı
- 4) Yeniden Okuma

Bu dört ana evre etrafında ilerleyen NET oturumlarının önceden yapılandırılması (süre ve seans sayısı açısından) oldukça önemlidir. Genellikle ilk oturum, bireyin ruhsal durumunun değerlendirilmesi ve psikoeğitim verilmesiyle başlar. Bireye, içinde olabileceği ruhsal durumla ilgili açıklama yapıldıktan sonra, insan hakları evrenselliği hakkında (travma ve istismar mağdurları için) bir açıklama yapılır, demografik bilgiler toplanır, tıbbi ve psikiyatrik özgeçmiş alınır, mevcut durum değerlendirmesi yapılır ve sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda bireye bilgi verilir.

İkinci adımda ise öncelik bireyle rahat ve güvene dayalı bir ilişki kurulmasıdır. Çünkü birey, yaşam olaylarını tüm ayrıntılarıyla anlatma konusunda isteksizlik yaşayabilir, özellikle TSSB'li bireylerin kafası karışık olabilir. Bu süreç, yaşam çizgisini (kalın bir ip kullanılır) düz bir zemine serme ile başlar. Olaylarla ilgili duygusal yaşantılara çok girmeden, olaylarla ilgili kronolojik olarak bilgiler alınır. Bireysel özellikler ve bireye özgü durumlar bu süreçte fark edilir. Burada alınan bilgiler, ileride oturum sürecinde değinmek ve referans vermek açısından oldukça önemlidir. Yaşam çizgisi oluşturulduktan sonra, kronolojik olarak her olay tek tek işlenir. Bireyin anlattıkları ayrıntılı bir şekilde oturum sonrasında yazıya dökülür (oturumun kısa versiyonu). Bir sonraki oturumda, bireye bu yazılı anlatı okunur ve eksiklikler ya da yanlışlar varsa düzeltilir. Ardından oturuma kaldığı yerden devam edilir. Son oturumda, yazılı belge (tüm seanslar) bireye sesli olarak okunur. Danışan ve terapist yazılı anlatının altına imza atarlar. İmzalanan belgenin bir kopyası danışana verilir, diğer kopyası ise gerektiğinde bilimsel amaçlar için kullanılmak üzere saklanabilir. Aşağıda, yapılandırılmış oturumlarla ilgili detaylı bilgi verilmiştir.

1. Oturum: Tanı- değerlendirme ve psikoeğitim

Genellikle ilk seans veya bazı durumlarda ilk seans öncesinde, bireyin psikiyatrik hastalık geçmişi belirlenir, TSSB ve varsa komorbid bozukluklar tespit edilir (TSSB için genellikle klinisyen tarafından uygulanan TSSB ölçeği/CAPS-5 gibi klinik değerlendirme formlarının kullanılması tavsiye edilir). Ardından problem alanları çerçevelendirilir, bireyle ilgili detaylı bilgi alınır ve tedavi

hedefleri belirlenir. Tanı ve değerlendirme sonrasında, bireye bir sorusu olup olmadığı sorulur. Eğer varsa, mutlaka yanıtlanır; yoksa psikoeğitime geçilir.

Psikoeğitimde, bireyin şu anki durumu ile ilgili bilgilendirme yapılır, bu durumda yalnız olmadığı vurgulanır ve bireyin içerisinde bulunduğu durum ‘normalleştirilir’ (yaşanan olumsuz yaşantılardan kaynaklı olarak bu gibi semptomların deneyimlenmesinin normal olduğu bilgisi verilir). Ayrıca, var olabilecek semptomlarla (özellikle TSSB ile ilişkili olabilecek depresyon, stres, kaygı, uykusuzluk, hayattan zevk almama, öz-değersizleştirme, boşluk hissi, iletişim/aile çatışmaları gibi) ilgili bilgilendirmeler yapılır.

Psikoeğitimin yoğunluğu ve içeriği, bireyin ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Örneğin, bir çocukla çalışılıyorsa, çocukların anlayabileceği ve aşına olduğu kelimeler seçilerek gerekli durumlarda çizim ya da oyuncaklar üzerinden veya metaforlarla anlatım yapılması daha etkili olacaktır. Bunun yanı sıra, mülteciler gibi dili kullanma konusunda zorluk yaşayabilecek bireyler için tercüman kullanılması veya bireyin eğitim seviyesine göre psikoeğitim verilmesi çok önemlidir (Schauer vd., 2024).

Psikoeğitimin amacı; bireyin yaşadıklarını anlayabilmesi, açıklayabilmesi ve normalleştirerek içinde bulunduğu durumun travmatik deneyimlerin bir sonucu olduğunu kabul etmesidir. Diğer bir deyişle; bireye fonksiyonel olmayan duygu, düşünce ve davranışları hakkında bilgi vermek, farkındalık kazandırmak, tepkileri normalleştirmek (tepki ve davranışların anlaşılır olduğu) ve gerçekçi kabullenme sağlamaktır. Bu nedenle, açıklamalar yapılırken bireyde kafa karışıklığına yol açmadan bütün sorulara yanıt verilmelidir. Psikoeğitimin sonlarına doğru, süreç hakkında konuşulur; oturum sayısı, süresi ve işleyişle ilgili açıklamalar yapılarak oturum sonlandırılır.

2. Oturum: Yaşam çizgisi oluşturma

Psikoeğitimden sonra, ikinci oturum yaşam çizgisi oluşturmaya ayrılır. Yaşam çizgisi, NET’in sembollerinden biri haline gelmiş önemli bir parçadır. Bu çizgi, kişinin yaşam hikayesini ritüelleştirir ve sembolik olarak temsil eder (Schauer vd., 2025). Yaşam çizgisi, zamanın kesintisiz akışını temsil eden bir ip veya şerit ile gösterilir. Genellikle hayatın devam ettiğini belirten, ucu kapalı bir ip yumağının düz bir zemine serilmesiyle oluşturulur. Yaşam çizgisinin yere yerleştirilmesi işlemi, birey tarafından yapılır. Bu sayede, yaşam çizgisi oluşturulurken bireyin hayatının kontrolünü eline alması teşvik edilir. Ardından, bireyin doğum sembol aracılığıyla yaşam çizgisinin en başına yerleştirilir. Burada, NET’in ayrılmaz bir parçası olan semboller kullanılır. Bu semboller çiçekler ve taşlardan oluşur. Çiçekler; bireyin yaşamında meydana gelen olumlu, pozitif, mutlu ve başarılı anları temsil ederken, taşlar; birey için acı veren, olumsuz ve travmatik yaşam olaylarını simgeler. Ayrıca, bazı durumlarda, mum ve odun/çalı parçası gibi semboller de kullanılabilir. Mum, bir yakının ya da sevilen birinin/evcil hayvanın ölümü ve yas gibi durumlar için, odun/çalı parçası ise birey şiddet görmüşse ya da şiddet uygulamışsa bu durumları ayırt etmek amacıyla kullanılabilir. NET’in geliştiricileri; sembollerin çeşitlendirilmemesini (oyuncak kullanma, sevilen bir kişisel eşyanın kullanılması gibi) ve yaşam çizgisinin bu çerçevede oluşturulması gerektiğini tavsiye etmektedir. Ancak kullanılan çiçek, taş, mum ve çalı parçalarının niteliksel olarak çeşitlendirilmesi önerilmektedir. Örneğin, daha travmatik yaşantılar için daha büyük ve siyah taşlar, birey için çok mutluluk verici bir yaşam olayı için ise büyük ve canlı renkli çiçekler kullanılabilir. Bu sayede yaşam olayları birbirinden niteliksel olarak kolayca ayırt edilebilir.

Yaşam çizgisinin en başına bireyin doğumuna ilişkin seçtiği sembol yerleştirilir. Ancak, doğumdan önce bireyin yaşamını ya da ailesini etkileyen büyük bir yaşam olayı varsa (taşınma, ekonomik durumdaki değişiklikler, bir aile ferdinin kaybı veya ailedeki hastalıklar gibi) ve birey gerekli görürse bu olay/olaylarla da yaşam çizgisine başlanabilir. Birey, yaşamında meydana gelen

olumlu ve olumsuz tüm yaşantıları doğumdan şimdiki zamana kadar yaşam çizgisinde sembolleştirilerek yerleştirir ve böylece yaşam çizgisi oluşturulur. Yaşam çizgisine semboller yerleştirilirken, olaylarla ilgili çok detaya girilmeden, bireyin hatırlayabildiği bağlamsal bilgiler alınır. Yer (şehir, ev, okul, sokak gibi) ve zaman (yıl, ay, gün, mevsim, günün saat dilimi veya paralel yaşam olayları) ile ilişkili bilgiler alınır. Bunları bir iki kelime ile etiketlemesi/isimlendirmesi istenir. Ancak, burada amaç bireyi olaya maruz bırakma olmadığı için bu bilgiler sonradan hatırlanabilmesi ve referans alınabilmesi amacıyla sembollerin yanına not şeklinde bırakılır. Yaşam çizgisi, kronolojik bir biçimde şimdiki zamanla sona erer. Birey ve terapist, bir araya gelerek bir bütün olarak gestaltı inceler. Bu noktada yapılan çalışmayı takdir etmek ve değerlendirmek önemlidir (Schauer vd., 2024). Bu sürecin bir oturum içinde tamamlanması ve bir sonraki oturuma sarkmaması oldukça önemlidir.

3. Oturum: Anlatıya başlama

Bir sonraki oturum, yaşam çizgisindeki ilk olayın (sembolün) anlatımı ile başlar. Yaşam çizgisi genellikle doğumla başladığı için bireyin ailesi ve doğduğu ortam hakkında olabildiğince bilgi alınmaya çalışılır. Ardından, bir sonraki sembole geçilerek kronolojik olarak ilerlenir. Bir sembol üzerinde ne kadar süre harcanacağı, o olayın birey için taşıdığı öneme bağlı olarak değişir. Ancak, olumlu ve pozitif olaylar hakkında konuşmak 15 dakikayı geçmemelidir; olumsuz ve travmatik yaşantılara ise gerektiği kadar zaman ayrılmalıdır. Olay hakkında konuşmadan önce bağlamsal bilgiler açıkça anlatılmalı ve detaylandırılmalıdır:

Zaman ve mekan: Olayın gerçekleştiği zaman, yaşam dönemi, yılın zamanı, günün saati, günün belli bir anı.

Konum ve eylem: Kişi neredeydi? Olay nerede gerçekleşti? Kişi o sırada ne yapıyordu? Ne Yapacaktı?

Başlangıç: Olayın başlangıcı ile ilgili detaylı bilgi paylaşımı (Schauer vd., 2024).

Olayın (özellikle de travmatik olayın anlatımında) klinisyen ve birey ‘Yavaş çekim modu’na geçer. Kişiden olayın başlangıcını zihninde canlandırması istenir. Olay, bu noktadan itibaren ayrıntılarıyla işlenmeye başlanır ve her şey sırayla ele alınır. Bireyin neyi algıladığını anlamasına yardımcı olmak önemlidir. Özellikle fiziksel duyular, düşünceler, davranışlar, nesnelerin şekli, rengi, kokusu, sesi gibi detaylar hakkında olabildiğince soru sorulur ve birey bu bilgileri paylaşmaya cesaretlendirilir. Böylece, olayla ilişkili duyu ve duyguların tekrar aktive olması sağlanarak anısal çağrışımlar takip edilir ve ipuçları anımsatıcılar aracılığıyla açığa çıkarılır. Gerçeklik pekiştirilir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli şey; kaçınma, dissosiyasyon ve geri dönüşlerin önüne geçilmesidir. Maruz bırakma ve yeniden yaşantılama, terapi sürecinde istenen bir süreç olsa da dissosiyasyon tehlikelidir ve deneyimlenmesi istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle, bireyin klinisyen ile “burada ve şimdi”de kalmasının pekiştirilmesi oldukça önemlidir. Yeniden yaşantılama gerçekleştikten sonra, olayı günün geri kalan bağlamına oturtmak ve parçaları birleştirmek otobiyografik belleğin bütünlüğünü sağlamak açısından önemlidir (Schauer vd., 2025). Örneğin, olay öğleden sonra gerçekleşiyse, günün geri kalanında ne yaptığı ile ilgili bilgi almak önemli olacaktır. Travmatik ve olumsuz yaşantıların anlatımı sırasında duygusal ve duyusal (sensöri) anıları olabildiğince canlandırmak önemlidir. Bu canlandırma ile amaç duyusal, bilişsel, duygusal ve fizyolojik unsurların (olayla ilişkili) aktivasyonunu sağlamak ve bu bileşenleri entegre etmektir. Bu entegrasyon bir bileşenin aktivasyonunun diğer bileşenin aktivasyonunu da tetikleyeceği için soğuk bellek ve sıcak belleğin sağlıklı entegrasyonunu sağlayacaktır. Böylece travmatik yaşantıyla ilişkili otobiyografik belleğin tutarlı ve işlevsel bir şekilde yeniden işlenmesi gerçekleşecektir. Sıcak bellek ve soğuk bellek entegrasyonunu sağlamak için travmatik yaşantı unsurlarını hedef alan sorular Schauer ve meslektaşları (2025)’ı tarafından NET’in el kitabında örneklendirilmiştir.

Bu çalışma oturumun sonunu getirir. Oturumdan sonraki birkaç günde yaşananlar ve anlatılanlar üzerine ciddi düşünme ve içgörü kazanma süreci olabilir. Bu bilişsel yeniden yapılandırma sürecinin doğal bir parçasıdır. Terapist oturumdan sonra hemen bireyin anlattıklarını ve hissettiklerini (oturum sırasında not almalıdır) tüm detayları ile kağıda dökerek onun bakış açısıyla yazmalıdır.

4. Üçüncü oturum ve sonrası: Anlatıya devam etme

Her oturumun başında danışana haftasının nasıl geçtiği, nasıl bir ruh hali içerisinde olduğu, anlattıkları ile ilgili neler düşündüğü ve hissettiği ile ilgili sorular sorulmalıdır. Böylece hafta içerisinde meydana gelen bilişsel değişiklikler ve otobiyografik belleğin yeniden işlenmesine bağlı olarak yeni detaylar hatırlanabilir ve birey olaya ilişkin yeni farkındalıklar ile gelebilir. Bunu ardından bir önceki oturumda terapistin yazıya döktüğü anlatı bireye okunur. Bireyden dikkatlice dinlemesi ve okunanları yeniden gözünde canlandırmasını istenir. Varsa üzerinde değişiklikler/düzeltilmeler yapılır ve yaşam çizgisine bir sonraki sembolün anlatımı ile devam edilir. Son oturuma kadar bütün oturumlar bu şekilde devam eder.

Son Oturum: Yeniden okuma

İlk anlatı seansından başlayarak, bireyin anlatısını içeren tüm yazılı belge sesli olarak danışana okunur. Yine düzeltmek veya eklemek istediği bir şey varsa, ekleme ve düzeltmeler yapmasına müsaade edilir. Bir kopyası bireyde bir kopyası terapistte olmak üzere paylaşılır. Her ikisi de altına imza atar. Bu ortak imza ve anlatılanların gerçekliği üzerinde karar kılma, Şahitlik Terapisinin en temel bileşenidir. Ancak bilinmelidir ki, bazı durumlarda travmatik yaşantıya sahip bireyler (özellikle cinsel istismar ve ihmal mağdurları) bu belgenin kopyasının kendilerinde bulunmasını istemeyebilir ve hayatlarının bu acı verici olaylarını geride bırakarak yaşama yeni bir sayfa açmayı tercih edebilirler. Bu durumda, bireyin rızası ve isteği dikkate alınarak hareket etmek oldukça önemlidir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu yazılı belge Avrupa'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde, insan hakları savunuculuğu yapmak amacıyla klinisyen eşliğinde hazırlandığı için yasal bir kanıt olarak kullanılabilir.

Başarılı bir müdahalenin ardından birey; artık daha işlevsel düşünebilen, sosyalleşebilen, yeni olanak ve fırsatları değerlendirebilen, kendine yönelik kabulü ve farkındalığı artmış, güçlü yönlerini bilen, suçluluk ve isteksizliği azalmış, hayata karşı motivasyonu artmış, güvenli dünya inancı oluşmuş bir birey haline gelir (Schauer vd., 2005; Mørkved vd., 2014; Schauer vd., 2025).

Anlatısal Maruz Bırakma Terapisinde Terapistin Rolü

NET tekniğinde, birey özellikle duyuşsal ve bağlamsal bilgilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla yaşadığı olayları olabildiğince detaylı anlatmaya cesaretlendirilir; böylece anılara ait duyuşsal, bilişsel ve duyuşsal bileşenleri yeniden deneyimlemesi sağlanır (Mørkved vd., 2014). Çünkü, otobiyografik belleğin sağlıklı entegrasyonu ve kronolojik akışının sağlanabilmesi için bireye olayı yeniden yaşatmak (maruz bırakma) ve şimdi-burada güvende olduğunu anlamasına yardımcı olmak (alıştırma) NET'in temel prensiplerindendir. TSSB'li bireylerin; kendilerine ve dünyaya yönelik bozulmuş algıları ile günlük yaşamdaki işlevselliklerindeki azalma düşünüldüğünde; terapist hem NET tekniğinin hassasiyetinden hem de travmanın doğasından kaynaklanan birçok sorumluluk düşmektedir (Robjant & Fazel, 2010).

Temel olarak; anlatı boyunca bireye ve yaşadıklarına saygı duyulmalıdır. Bu saygı ve kabul, empati ile birleşerek gerekli görülen zamanlarda sözlü olarak yansıtılmalıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır: Birincisi, terapi sürecinde bireyin anlatımında tutarsızlıklar varsa, her ne kadar bireyin gerçekliği olsa da, nazikçe ve uygun görüşme becerileri kullanılarak bunlara dikkat çekilmelidir. İkinci nokta ise; bireye kabul ve empati gösterirken onu

kahramanlaştırmamaktır. Çünkü TSSB'li bireyler, genellikle çok zor yaşam olaylarını deneyimlemiş olduklarından terapistler bazı durumlarda yüceltici tepkiler verebilirler. Ancak bu durum, terapistin gözündeki 'kahramanlaştırılan/yüceltilen imajını' yıkmamak için, bireyin daha sonra değineceği utanç verici veya kendini küçük düşüren olayları anlatmasının önüne geçebilir. Ayrıca yapmacıklıktan kaçınmak, uygun ve ölçülü tepkiler vermek önemlidir.

Travmatik yaşantıların doğasından kaynaklı olarak bireylerde 'konuşamama ve sözel olarak ifade edememe' gibi durumların görülmesi oldukça normaldir (Schauer ve ark., 2024). Bu yüzden terapist zaman zaman danışanın kendisini sözel olarak ifade etmesine yardımcı olacak bir takım cesaretlendirici görüşme tekniklerinden faydalanabilir. Ancak yine terapistin birey yerine yorum yapmaması önemlidir. Çünkü yaşadıkları ve hissettikleri konusunda gerçekten bilgi sahibi olan kişi bireydir. Yanlışlar ve doğrular konusunda yargılamaya gidilmemeli, bireyin kendi gerçekliği onun açısından kabul edilmeli ve düzeltilmeye çalışılmamalıdır. Buna ek olarak, travmatik yaşantı deneyimi olan bireyler sessizliklerini genellikle bedensel tepkilerle (elleri ovuşturma, ağlama, titreme, terleme, hızlı nefes alıp verme ve huzursuz hisetme) dışavurabilirler. Yine böyle durumlarda bireye; bedensel tepkileri hakkında geri bildirimde bulunmak hem farkındalığını artıracaktır hem de terapistin süreç boyunca onun yanında olduğunu, değer verdiğini ve anlaşıldığını hissetmesine olanak tanır.

Terapist, NET seansları boyunca bireyin söylediklerini anladığından emin olmalıdır. Anlamadığı noktaları sormadan geçmemeli, kafa karışıklığını gidermeli ve uygun bir şekilde anlayamadığını belirterek açıklama istemelidir. Örneğin, 'Ne dediğinizi tam olarak anlayamadım. Tekrar eder misiniz?' (Schauer vd., 2024) gibi bir cümle, kafa karışıklığını ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve bireye anlaşılmasına çalışıldığını göstererek yalnızlık hissinin önüne geçer.

Yukarıda da belirtildiği gibi, travmatik yaşantıların olabildiğince detaylı bir şekilde anlatılması, otobiyografik belleğin yeniden ve işlevsel entegrasyonu için oldukça önemlidir. NET tekniğine yeni başlayan terapistler genellikle detaylara inmekte zorlandıklarını belirtmektedirler (Robjant & Fazel, 2010; Schauer vd., 2011). Bunun üstesinden gelmenin anahtarı, anlatı sırasında bireyin söylediklerini terapistin zihninde bir film gibi canlandırarak tutarsız parçaları düzeltmek ve eksik kalan kısımları sormak suretiyle doldurmaktır. Böylece terapist, olayla ilgili zihninde daha somut bir tablo oluştururken, bireyi de olayla ilgili daha detaylı bir anlatıma cesaretlendirmiş olur. Diğer bir deyişle, imajinasyon tekniği çift taraflı bir şekilde işlemektedir.

Terapist, anlatı sürecine zarar verecek davranışlardan kaçınmalı ve öngörülebilir bir şekilde dürüstçe hareket etmelidir. Özellikle TSSB'li bireylerle çalışmanın doğasından kaynaklanan güvenin oluşturulması ve korunması adına, terapist içten ve sıcak bir tutum benimsemeli ve bireye gerektiği noktalarda esneklik sağlamalıdır. Örneğin, birey haftalık süreçte yaşadığı önemli bir olayı terapi seansında konuşmak isteyebilir. Bu durumda, birey geçirtilmemeli ve gerekli zaman ayrılmalıdır. Ancak, bu durumun tüm oturumu ele geçirmesine izin verilmemelidir. NET tekniği, yapılandırılmış bir teknik olduğu için oturuma başlamadan ve gerekli durumlarda süreç hakkında bireye yeniden bilgilendirme yapılmalı ve kafasında soru işaretlerinin oluşmasına izin verilmemelidir. Terapist, bazı durumlarda, danışanına kendini sınırlı bir şekilde açarak onu anladığını ifade edebilir. Fakat bu durum genellikle tavsiye edilmez. Anlatı süreci boyunca terapist, kendisinden bahsetmez (gerektiğinde sınırlı bir şekilde olabilir), rastgele yorum yapmaz, didaktik bir tutum sergilemez, tavsiyelerde bulunmaz ve duruşu ile tepkilerinin farkında olur. Örneğin; derin iç çekme, iğrenme, kahkaha gibi tepkileri dışavurma konusunda dikkatli olmalıdır (Schauer vd., 2025). Ayrıca terapist, hareketleri konusunda öngörülebilir olmalı ve seans sırasında herhangi bir davranışta bulunacaksa (örneğin; koltuğu düzeltmek, perdeyi çekmek, kapıyı kapatmak gibi) bunun için bireye açıklama yapmalıdır.

Diğer terapi süreçlerinde olduğu gibi, NET de birey ve terapist arasındaki en yüksek gizliliğe ve bağlılığa tabiidir. Bu nedenle, güvence vermek ve bireyin rızası olmadan üçüncü kişilerle hiçbir

bilginin paylaşılmayacağına altının çizilmesi önemlidir. Ayrıca bu süreç, güven ve gizlilik ilkeleri etrafında inşa edildiği için, bireyin gönüllülüğü esastır. TSSB'li bireyler, yaşadıkları deneyimlerin anlaşılmayacağı veya anlatılamayacağı düşüncesine kapılsalar da, anlatım konusunda cesaretlendirilmeleri gerekmektedir. Öte yandan, eğer birey deneyimlerini anlatmak istemiyorsa; terapist her zaman sınırlarına saygı göstermeli, onu bunaltmamalı ve anlatması için baskı yapmamalıdır. Ancak terapist, olası sonuçlar ve sorumluluklar hakkında da bireyi uyarmalıdır (Schauer vd., 2024).

Anlatısal Maruz Bırakma Terapisinin Farklı Formatları

NET tekniği, başlangıçta yetişkin mülteci popülasyonunun TSSB tedavisi için geliştirilmiş olsa da, zamanla farklı popülasyonlara uygulanmış ve çeşitli adaptasyon çalışmaları yapılmıştır.

NET'in çocuklar ve ergenler için geliştirilen versiyonu **KIDNET**'tir. İlk çalışmalar, Konstanz Üniversitesi'nin ayaktan çocuk hastalarla yürüttüğü klinik çalışmalara ve Sri Lanka'da göçe zorlanmış çocuklarla yapılan araştırmalara dayanır. Bu çalışmaların sonuçları KIDNET'in özellikle yerinden edilmiş ve organize suç mağduru çocuklar üzerinde etkili olduğunu kanıtlamıştır (Schauer ve ark. 2004; Onyut ve ark., 2005). Yetişkinlerden farklı olarak, KIDNET'te güven kazanımı daha kritik bir konudur. Özellikle travmatik yaşantının sebep olabileceği bağlanma sorunlarının yaralarını kapamaya çalışırken terapötik etkileşimle duygusal bağın yeniden kurulması hedeflenir. Bu güveni sağlamak için, yaşam çizgisi oluşturulurken veya anlatılar sırasında çizimler ve figürler gibi görsel materyallerin kullanılması gerekebilir. Yaratıcılık ve oyun kullanımı çocukların anlatılarını detaylandırmak için oldukça faydalı olabilir. Bu bağlamda, Schauer ve ark. (2024), KIDNET'te yaşam çizgisi oluşturma sürecinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Yaşam çizgisi oluşturma sürecinde kullanılan yaratıcılık, çocukların engelleri aşmasına yardımcı olabilir ve bu sayede çocuklar kendilerini daha rahat bir şekilde ifade edebilirler. Yetişkinlere göre, çocukların yaşam çizgileri yaşa bağlı olarak daha kısa olabilir; ancak bazı durumlarda bir yetişkinin yaşam çizgisine yakın uzunlukta olabilir. Ayrıca, KIDNET'te, yaşam çizgisi sadece doğumdan şimdiki zamana kadar değil, geleceği de temsil edecek şekilde sembollerle zenginleştirilebilir. Örneğin, "Okulu bitirdiğimde", "Evlendiğimde" gibi yaşam olayları, uygun sembollerle yaşam çizgisi üzerine yerleştirilebilir (Schauer vd., 2024).

NET'in suçlular için olan versiyonu ise **FORNET**'tir. FORNET, NET'in temel ilkelerine ve unsurlarına ek olarak 'şiddetin uygulanması'na odaklanır. Amaç, faillerin şiddet içeren davranışları üzerinde kontrol kazanabilmelerine yardımcı olmaktır (Crombach vd., 2015).

KIDNET ve FORNET'in yanı sıra, COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalar doğrultusunda, Kaltenbach ve meslektaşları (2021) **e-NET** olarak bilinen NET'in online versiyonunu geliştirmiş ve uygulama süreci ile ilgili bir el kitabı yayınlamıştır. NET'in ayrıca travma mağduru yaşlılar için geliştirilen **ElderNET** ve ortak travmaya mağruz kalmış topluluklar (köyler, etnik gruplar, aileler gibi) için bireysel travma anlatılarının grup süreciyle tedavi edilmeye çalışıldığı **NETfacts** versiyonu da mevcuttur (Schauer vd., 2025).

Anlatısal Maruz Bırakma Terapisinin TSSB ve Komorbid Bozuklukların tedavisinde Etkiliği

NET, temel olarak Schauer ve meslektaşları (2005) tarafından, özellikle çatışma sonrası bölgelerde yaşayan mülteci popülasyonunun psikolojik sorunlarını tedavi etmek amacıyla tasarlanmış ve uygulanmıştır. Kısa süreli ve etkili bir terapi tekniği olarak dünya çapında hızla benimsenmiş ve araştırma alanı genişlemiştir.

NET'in etkililiğini araştıran ilk deneysel çalışma, Neuner ve meslektaşları (2004) tarafından Uganda'ya yerleşen 43 Sudanlı mülteciyle gerçekleştirilmiştir. 2000-2001 yıllarında yürütülen bu

çalışmada, Uganda'nın kuzey bölgesine yerleşen ve iç savaştan kaçan 43 Sudanlı mülteci ile çalışılmıştır. Katılımcılar, rastgele üç gruba ayrılmıştır: Birinci gruptaki katılımcılar (N=12) yalnızca bir oturum psikoeğitim almış, ikinci gruptakiler (N=14) psikoeğitime ek olarak üç oturum Destekleyici Psikolojik Danışmanlık almış ve üçüncü gruptaki katılımcılar ise Psikoeğitime ek olarak üç NET oturumu almışlardır. Araştırmacılar, yerel çevirmenler aracılığıyla çalışmayı yürütmüş ve dört farklı zamanda veri toplamışlardır. Öntest-sontest ve 4 aylık ile 1 yıllık izleme ölçümleri sonucunda gruplar arasında anlamlı farklar olduğu ve NET uygulanan grubun TSSB semptomlarında ciddi bir azalma görüldüğü, bu azalmanın 1 yıl sonra dahi remisyon halinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İkinci deneysel çalışma ise Bichescu ve arkadaşları (2007) tarafından yapılmıştır. Araştırmacılar, NET ve Psikoeğitim gruplarından oluşan bir randomize kontrollü çalışma yürütmüş ve 18 Romanyalı politik tutuklu ile çalışmışlardır. Birinci grup (kontrol grubu) yalnızca bir oturum psikoeğitim alırken; ikinci grup olan deney grubuna ise NET uygulanmıştır. Yapılan ön ve sontest ölçümleri, deney grubundaki katılımcıların TSSB ve depresyon düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir azalma olduğunu göstermiştir. Çalışmanın tamamlanmasından 6 ay sonra elde edilen izlem ölçümlerinde de, NET uygulanan grubun psikoeğitim grubuna kıyasla TSSB ve depresyon düzeylerinin azaldığı; deney grubundakilerin %56'sının TSSB semptomlarının düştüğü, ancak kontrol grubunda bu oranın yalnızca %11 olduğu rapor edilmiştir.

Yukarıda da açıklandığı gibi, NET'in etkililiğini değerlendirmek amacıyla deneysel çalışmalar yürütülmüş; psikoeğitim, destekleyici psikolojik danışmanlık, grup terapileri, stres aşılama eğitimi, meditasyon ve rahatlama, şimdi odaklı terapi gibi diğer psikolojik müdahalelerle karşılaştırılmış ve NET'in TSSB'nin tedavisindeki üstünlüğü kanıtlanmıştır (Neuner vd., 2004; Bichescu vd., 2007; Neuner vd., 2008; Catani vd., 2009; Schaal vd., 2009; Neuner vd., 2010; Ruf vd., 2010; Hensel-Dittmann vd., 2011; Lely vd., 2019). Orang ve arkadaşları (2018), İranlı partner şiddetine maruz kalmış kadınlarla yürüttükleri çalışmada NET tekniğinin depresyon ve algılanan stresin azalmasında anlamlı bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, Zang ve arkadaşları (2013), 2008 yılında Çin'de meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan Siçuan depremini deneyimleyen depremzedelerle NET'in kısa formunun (4 oturum) etkililiğini değerlendirmiş ve TSSB, depresyon ve anksiyete semptomlarının azalmasında etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Bunun yanı sıra, NET'in etkililiği yalnızca TSSB tedavisinde değil, aynı zamanda TSSB ile bağlantılı çeşitli psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde ve farklı popülasyonlarda da ortaya koyulmuştur. Örneğin, alanyazındaki diğer çalışmalar da NET'in TSSB'nin eşlik ettiği sınırdaki kişilik bozukluğu, uyku problemleri ve intihar düşüncelerinin tedavisindeki etkinliği kanıtlamıştır (Stenmark vd., 2013; Halvorsen vd., 2014; Pabst vd., 2014; Steuwe vd., 2016; Weinhold vd., 2017).

Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında, mülteci popülasyonunda TSSB semptomlarını hafifletmek için tasarlanan NET'in, TSSB ve komorbid bozuklukların tedavisinde de etkili olduğu ve kompleks travmanın tedavisinde farklı popülasyonlarda uygulanabilirliği yapılan çalışmalarla kanıtlanmış; doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlarda bile kısa formunun etkililiği deneysel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Sonuç ve Öneriler

Alanyazında yürütülen çalışmalar pek çok psikolojik müdahale yönteminin özellikle Batılı, Eğitilmiş, Zengin, Sanayileşmiş ve Demokratik toplumlar için uygun olduğunu; evrensel uygulamalar noktasında yetersiz kalabileceğini ve uygun olmayabileceğini vurgulamaktadır (Kleinman & Benson 2006; Henrich vd., 2010; Li vd., 2023). Dolayısıyla evrensel olarak uygulanabilir ve etkililiği yüksek tekniklerin geliştirilmesi ve klinik uygulamalarda kullanılması kritik bir önem taşımaktadır.

NET'in temel gücü, çoklu travma öykülerine sahip bireylerde kronolojik bir yaşam çizgisi üzerinden çalışarak hem travmatik hem de olumlu anıları bütünleştirmesidir. Bu durum; özellikle

mülteci, savaş mağduru veya çocukluk çağı istismar öyküsü olan bireylerde, travmanın yaşam öyküsündeki yerini anlamlandırmaya yardımcı olur (Lely vd., 2019). Bununla birlikte, NET'in bazı sınırlılıklarının olduğunu da kabul etmek gerekir. Öncelikle, yöntem yoğun bir anlatı süreci gerektirdiği için, ciddi dissosiyatif belirtileri olan veya anlatı sırasında aşırı duygusal aktivasyon yaşayan bireylerde uygulama güçleşebilir. Bunun için sürecin ilk adımı olan Psikoeğitim ve değerlendirme aşamasında dissosiyasyon belirtilerini ölçmek için bir değerlendirme aracının kullanılması ve sürece bu durumun göz önünde bulundurularak devam edilmesi faydalı olabilir. Ayrıca, NET'in etkinliği büyük ölçüde terapistin anlatıyı yapılandırma becerisine ve kültürel duyarlılığına bağlıdır; bu durum, farklı kültürel bağlamlarda terapistin çokkültürlülük duyarlılığını kaçınılmaz kılar. Uygulamadaki güçlükler arasında, travmatik anıların detaylı olarak yeniden hatırlanması sırasında ortaya çıkan yoğun duygusal tepkiler ve terapötik ittifakın korunması gerekliliği de öne çıkar. Bu süreç hem danışan hem de terapist için yüksek düzeyde psikolojik dayanıklılık gerektirir. Ayrıca, NET genellikle kısa süreli bir protokol olarak tasarlanmış olsa da çoklu travma öykülerinde seans sayısının artması kaçınılmazdır; bu durum, zaman ve kaynak açısından sınırlılık yaratabilir.

Diğer travma odaklı terapilerle karşılaştırıldığında NET'in avantajları arasında, özellikle çoklu travma öykülerinde etkinliği ve yaşam öyküsünü bütünleştirerek kimlik duygusunu güçlendirmesi sayılabilir. EMDR veya Uzun Süreli Maruz Bırakma Terapisi gibi yöntemler, genellikle tekil travmatik anılara odaklanırken, NET daha geniş bir perspektif sunar. Bununla birlikte, dezavantaj olarak, NET'in yapılandırılmış maruz bırakma teknikleri kadar semptom azaltımında hızlı etki göstermediği ve bazı çalışmalarda EMDR'ye kıyasla daha düşük etkinlik bildirilmiş olması dikkat çekmektedir (Watts vd., 2013).

Öte yandan NET'in evrensel ve ortak kültürlerin ürünü olan birçok öğeyi (otobiyografik anlatı ve hikayeleştirme gibi) içinde barındırması, özellikle TSSB'nin tedavisinde etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Dünyanın birçok yerinde geniş kullanım alanına sahip olan bu teknik, APA gibi ruh sağlığı alanında öncü kuruluşlar tarafından TSSB'nin tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmış ve önerilen bir terapi tekniğidir (APA, 2017). Ancak Türkiye'de henüz NET tekniği tam anlamıyla keşfedilmemiş olup bu alandaki araştırmalar sayıca yetersizdir. Alanyazında mevcut bir araştırmada NET'in Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin TSSB, depresyon, anksiyete, stres ve benlik bütünlüğü gibi değişkenler üzerindeki etkililiği üzerine odaklanılmıştır (Aysazcı Çakar, 2024). Araştırmanın sonuçları; NET'in Suriyeli mültecilerde TSSB, depresyon, anksiyete ve stres semptomlarını azaltma noktasında umut verici bulgular sunduğunu ve benlik bütünlüğü açısından anlamlı pozitif değişimler sağladığını göstermektedir. Bu noktada tekniğin Türkiye bağlamında kullanılabilmesi açısından psikoeğitim ve anlatı oturumlarında kullanılan dilin; bireyin eğitim düzeyine ve kültürel ifadelerine uygun olmasının göz önünde bulundurulması önemlidir. Hem insan yapımı hem de doğal afet kaynaklı travmatik yaşantı çeşitliliği ve potansiyeli yüksek olan ülkemizde deprem, göç, aile içi şiddet gibi sık karşılaşılan travmatik yaşantılar için NET protokolleri uyarlanabilir ve afet sonrası saha uygulamalarında NET'in kısa formu (4 oturumluk NET) kullanılabilir.

Tüm bu bilgiler ışığında, ülkemizin toplumsal ve bireysel travmatik yaşantı çeşitliliğine sahip olması, uygun müdahale tekniklerinin kısıtlılığı ve var olan terapi tekniklerinin eksikliği, acil afet ya da kriz durumlarında bu tekniklerin müdahale konusunda yetersiz kalmaları, kaynak ve zaman açısından erişilebilirliğin sınırlı olması gibi sebeplerle NET'in uygulama alanının ülkemizde yaygınlaştırılması büyük bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle araştırma alanının çeşitlendirilerek adaptasyon çalışmalarının yapılması, tekniğin çeşitli ve güçlü araştırma desenleri ile etkililiğinin kanıtlanması önemlidir. Bu tekniğin hem klinik ortamlarda hem de topluma hizmet eden kamu kurumlarında; risk altındaki bireylerin ruh sağlıklarını iyileştirmeye, güçlendirmeye ve

onları topluma kazandırmaya önemli katkılar sağlayacağı aşikardır. Bu sebeple NET'in Türkiye'de yaygınlaşması için psikolog ve psikiyatristlere yönelik Türkçe eğitim materyalleri ve süpervizyon programları oluşturulmalıdır. Gelecekte yürütülecek akademik çalışmaların; özellikle Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi deneysel çalışmalara öncelik vererek tekniğin Türkiye'deki etkililiği konusunda araştırmalar yapması, ülkemizde TSSB ve komorbid bozuklukların tedavisinde bu yeni, bütüncül, pratik ve değerli yaklaşımın eklenmesine olanak sağlayacaktır.

References

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- American Psychological Association. (2017). *Clinical practice guideline for the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD) in adults*. <https://www.apa.org/ptsd-guideline>
- Aysazcı-Çakar, F. (2024). *Investigation of the effectiveness of narrative exposure therapy in the Syrian refugee population and the potential role of it in self-concept clarity* [Doctoral dissertation]. University of Nottingham.
- Bichescu, D., Neuner, F., Schauer, M., & Elbert, T. (2007). Narrative exposure therapy for political imprisonment-related chronic posttraumatic stress disorder and depression. *Behaviour Research and Therapy*, 45(9), 2212–2220. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2007.03.013>
- Bradley, L. A., McKendree-Smith, N. L., & Cianfrini, L. R. (2003). Cognitive-behavioral therapy interventions for pain associated with chronic illnesses. *Seminars in Pain Medicine*, 1(2), 44–54.
- Brewin, C. R. (2014). Episodic memory, perceptual memory, and their interaction: Foundations for a theory of posttraumatic stress disorder. *Psychological Bulletin*, 140(1), 69–97. <https://doi.org/10.1037/a0033722>
- Brewin, C. R., Gregory, J. D., Lipton, M., & Burgess, N. (2010). Intrusive images in psychological disorders: Characteristics, neural mechanisms, and treatment implications. *Psychological Review*, 117(1), 210–232. <https://doi.org/10.1037/a0018113>
- Briere, J., & Scott, C. (2015). *Principles of trauma therapy: A guide to symptoms, evaluation, and treatment* (2nd ed.). Sage Publications.
- Catani, C., Kohiladevy, M., & Ruf, M. (2009). Treating children traumatized by war and tsunami: A comparison between exposure therapy and meditation-relaxation in north-east Sri Lanka. *BMC Psychiatry*, 9, Article 22. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-9-22>
- Cienfuegos, A. J., & Monelli, C. (1983). The testimony of political repression as a therapeutic instrument. *American Journal of Orthopsychiatry*, 53(1), 43–51. <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1983.tb03368.x>
- Cloitre, M., Courtois, C. A., Charuvastra, A., Carapezza, R., Stolbach, B. C., & Green, B. L. (2011). Treatment of complex PTSD: Results of the ISTSS expert clinician survey on best practices. *Journal of Traumatic Stress*, 24(6), 615–627. <https://doi.org/10.1002/jts.20697>
- Conway, M. A., & Fthenaki, A. (2000). Disruption and loss of autobiographical memory. In L. Cermak (Ed.), *Handbook of neuropsychology: Memory and its disorders* (pp. 257–288). Elsevier.
- Cowan, A., Ashai, A., & Gentile, J. P. (2020). Psychotherapy with survivors of sexual abuse and assault. *Innovations in Clinical Neuroscience*, 17(1–3), 22–26.
- Crombach, A., & Elbert, T. (2015). Controlling offensive behavior using narrative exposure therapy: A randomized controlled trial of former street children. *Clinical Psychological Science*, 3(2), 270–282. <https://doi.org/10.1177/2167702614543027>
- Crombach, A., & Siehl, S. (2018). Impact and cultural acceptance of the narrative exposure therapy in the aftermath of a natural disaster in Burundi. *BMC Psychiatry*, 18, Article 24. <https://doi.org/10.1186/s12888-018-1610-y>

- Cukor, J., Olden, M., Lee, F., & Difede, J. (2010). Evidence-based treatments for PTSD, new directions, and special challenges. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1208(1), 82–89. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2010.05793.x>
- Elbert, T., & Schauer, M. (2002). Burnt into memory. *Nature*, 419(6910), 883. <https://doi.org/10.1038/419883a>
- Foa, E. B. (2011). Prolonged exposure therapy: Past, present, and future. *Depression and Anxiety*, 28(12), 1043–1047. <https://doi.org/10.1002/da.20907>
- Foa, E. B., Hembree, E., & Rothbaum, B. O. (2007). *Prolonged exposure therapy for PTSD: Emotional processing of traumatic experiences therapist guide*. Oxford University Press.
- Foa, E. B., Hembree, E. A., Rothbaum, B. O., & Rauch, S. A. M. (2019). *Prolonged exposure therapy for PTSD: Emotional processing of traumatic experiences: Therapist guide* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Foa, B. E., Keane, T. M., & Friedman, M. J. (2000). Guidelines for treatment of PTSD. *Journal of Traumatic Stress*, 13(4), 539–588. <https://doi.org/10.1023/A:1007802031411>
- Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. *Psychological Bulletin*, 99(1), 20–35. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.99.1.20>
- Foa, E. B., & Rothbaum, B. O. (2001). *Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for PTSD*. Guilford Press.
- Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? *Behavioral and Brain Sciences*, 33(2–3), 61–135. <https://doi.org/10.1017/S0140525X0999152X>
- Halvorsen, J. Ø., Stenmark, H., Neuner, F., & Nordahl, H. M. (2014). Does dissociation moderate treatment outcomes of narrative exposure therapy for PTSD? A secondary analysis from a randomized controlled clinical trial. *Behaviour Research and Therapy*, 57, 21–28. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.03.004>
- Institute of Medicine. (2008). *Treatment of posttraumatic stress disorder: An assessment of the evidence*. National Academies Press.
- Kaltenbach, E., McGrath, P. J., Schauer, M., Kaiser, E., Crombach, A., & Robjant, K. (2021). Practical guidelines for online narrative exposure therapy (e-NET)—A short-term treatment for posttraumatic stress disorder adapted for remote delivery. *European Journal of Psychotraumatology*, 12(1), Article 1891726. <https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1891726>
- Katsounari, I. (2015). Narrative exposure therapy for treating PTSD with psychotic features: A case study. *Clinical Case Studies*, 14(5), 342–356. <https://doi.org/10.1177/1534650115575795>
- Kleinman, A., & Benson, P. (2006). Anthropology in the clinic: The problem of cultural competency and how to fix it. *PLoS Medicine*, 3(10), e294. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030294>
- Lely, J. C. G., Smid, G. E., Jongedijk, R. A., Knipscheer, J. W., & Kleber, R. J. (2019). The effectiveness of narrative exposure therapy: A review, meta-analysis and meta-regression analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, 10(1), Article 1550344. <https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1550344>
- Lang, P. J. (1977). Imagery in therapy: An information processing analysis of fear. *Behavior Therapy*, 8(5), 862–886. [https://doi.org/10.1016/S0005-7894\(77\)80157-3](https://doi.org/10.1016/S0005-7894(77)80157-3)

- Lang, P. J. (1979). A bio-informational theory of emotional imagery. *Psychophysiology*, 16(6), 495–512. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.1979.tb01511.x>
- Li, S., Xi, Z., Barnett, P., Saunders, R., Shafran, R., & Pilling, S. (2023). Efficacy of culturally adapted interventions for common mental disorders in people of Chinese descent: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 10(6), 426–440. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(23\)00091-8](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00091-8)
- Marcus, S. V., Marquis, P., & Sakai, C. (1997). Controlled study of treatment of PTSD using EMDR in an HMO setting. *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training*, 34(3), 307–315. <https://doi.org/10.1037/h0087791>
- Mollica, R. F., McInnes, K., Poole, C., & Tor, S. (1998). Dose-effect relationships of trauma to symptoms of depression and post-traumatic stress disorder among Cambodian survivors of mass violence. *The British Journal of Psychiatry*, 173(6), 482–488. <https://doi.org/10.1192/bjp.173.6.482>
- Mollica, R. F., Cardozo, B. L., Osofsky, H. J., Raphael, B., Ager, A., & Salama, P. (2004). Mental health in complex emergencies. *The Lancet*, 364(9450), 2058–2067. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(04\)17519-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)17519-3)
- National Institute for Health and Care Excellence. (2005). *Post-traumatic stress disorder (PTSD): The management of PTSD in adults and children in primary and secondary care*. NICE Guidelines.
- Neuner, F., Schauer, M., Klaschik, C., Karunakara, U., & Elbert, T. (2004). A comparison of narrative exposure therapy, supportive counseling, and psychoeducation for treating posttraumatic stress disorder in an African refugee settlement. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 72(4), 579–587. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.72.4.579>
- Neuner, F., Schauer, M., Roth, W., & Elbert, T. (2002). A narrative exposure treatment as intervention in a refugee camp: A case report. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 30(2), 205–209. <https://doi.org/10.1017/S1352465802002071>
- Neuner, F., Onyut, P. L., Ertl, V., Odenwald, M., Schauer, E., & Elbert, T. (2008). Treatment of posttraumatic stress disorder by trained lay counselors in an African refugee settlement: A randomized controlled trial. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 76(4), 686–694. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.76.4.686>
- Neuner, F., Kurreck, S., Ruf, M., Odenwald, M., Elbert, T., & Schauer, M. (2010). Can asylum-seekers with posttraumatic stress disorder be successfully treated? A randomized controlled pilot study. *Cognitive Behaviour Therapy*, 39(2), 81–91. <https://doi.org/10.1080/16506070903121042>
- Nixon, R. D. V., Sterk, J., & Pearce, A. (2012). A randomized trial of cognitive behaviour therapy and cognitive therapy for children with posttraumatic stress disorder following single-incident trauma. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 40(3), 327–337. <https://doi.org/10.1007/s10802-011-9566-7>
- Mørkved, N., Hartmann, K., Aarsheim, L. M., Holen, D., Milde, A. M., Bomyea, J., & Thorp, S. R. (2014). A comparison of narrative exposure therapy and prolonged exposure therapy for PTSD. *Clinical Psychology Review*, 34(6), 453–467. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.06.005>

- Onyut, L. P., Neuner, F., Schauer, E., Ertl, V., Odenwald, M., Schauer, M., & Elbert, T. (2005). Narrative exposure therapy as a treatment for child war survivors with posttraumatic stress disorder: Two case reports and a pilot study in an African refugee settlement. *BMC Psychiatry*, 5(1), Article 7. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-5-7>
- Orang, T., Ayoughi, S., Moran, J. K., Ghaffari, H., Mostafavi, S., Rasouljan, M., & Elbert, T. (2018). The efficacy of narrative exposure therapy in a sample of Iranian women exposed to ongoing intimate partner violence: A randomized controlled trial. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 25(6), 827–841. <https://doi.org/10.1002/cpp.2311>
- Pabst, A., Schauer, M., Bernhardt, K., Ruf-Leuschner, M., Goder, R., Elbert, T., Rosentraeger, R., Robjant, K., Aldenhoff, J., & Seeck-Hirschner, M. (2014). Evaluation of narrative exposure therapy (NET) for borderline personality disorder with comorbid posttraumatic stress disorder. *Clinical Neuropsychiatry*, 11(4), 108–117.
- Robjant, K., & Fazel, M. (2010). The emerging evidence for narrative exposure therapy: A review. *Clinical Psychology Review*, 30(8), 1039–1049. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.07.002>
- Ruf, M., Schauer, M., Neuner, F., Catani, C., Schauer, E., & Elbert, T. (2010). Narrative exposure therapy for 7- to 16-year-olds: A randomized controlled trial with traumatized refugee children. *Journal of Traumatic Stress*, 23(4), 437–445. <https://doi.org/10.1002/jts.20548>
- Schaal, S., Elbert, T., & Neuner, F. (2009). Narrative exposure therapy versus interpersonal psychotherapy: A pilot randomized controlled trial with Rwandan genocide orphans. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 78(5), 298–306. <https://doi.org/10.1159/000229768>
- Schauer, M., Neuner, F., & Elbert, T. (2005). *Narrative exposure therapy: A short-term intervention for traumatic stress disorders after war, terror, or torture*. Hogrefe & Huber.
- Schauer, M., Neuner, F., & Elbert, T. (2024). *Anlatışal maruz bırakma terapisi: Travmatik stres bozuklukları için kısa süreli tedavi* (F. Aysazcı Çakar, Trans.). (Original work published 2011).
- Schauer, M., Neuner, F., & Elbert, T. (2025). *Narrative exposure therapy (NET) for survivors of traumatic stress* (3rd ed.). Hogrefe.
- Schauer, E., Neuner, F., Elbert, T., Ertl, V., Onyut, L. P., Odenwald, M., & Schauer, M. (2004). Narrative exposure therapy in children: A case study. *Intervention*, 2(1), 18–32.
- Stenmark, H., Catani, C., Neuner, F., Elbert, T., & Holen, A. (2013). Treating PTSD in refugees and asylum seekers within the general health care system: A randomized controlled multicenter study. *Behaviour Research and Therapy*, 51(10), 641–647. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2013.07.002>
- Steuwe, C., Rullkötter, N., Ertl, V., Berg, M., Neuner, F., Beblo, T., & Driessen, M. (2016). Effectiveness and feasibility of narrative exposure therapy (NET) in patients with borderline personality disorder and posttraumatic stress disorder: A pilot study. *BMC Psychiatry*, 16(1), Article 254. <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0931-4>
- Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving & W. Donaldson (Eds.), *Organization of memory* (pp. 381–403). Academic Press.
- Udo, I., Javinsky, T. R., & Awani, T. (2022). Eye movement desensitisation and reprocessing: Part 1 – Theory, procedure and use in PTSD. *BJPsych Advances*, 30(4), 210–219. <https://doi.org/10.1192/bja.2022.24>

- Watts, B. V., Schnurr, P. P., Mayo, L., Young-Xu, Y., Weeks, W. B., & Friedman, M. J. (2013). Meta-analysis of the efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder. *Journal of Clinical Psychiatry*, 74(6), e541–e550. <https://doi.org/10.4088/JCP.12r08225>
- Weine, S. M., Kulenovic, A. D., Pavkovic, I., & Gibbons, R. (1998). Testimony psychotherapy in Bosnian refugees: A pilot study. *The American Journal of Psychiatry*, 155(11), 1720–1726. <https://doi.org/10.1176/ajp.155.11.1720>
- Weinhold, S. L., Göder, R., Pabst, A., Scharff, A. L., Schauer, M., Baier, P., Aldenhoff, J., Elbert, T., & Seeck-Hirschner, M. (2017). Sleep recordings in individuals with borderline personality disorder before and after trauma therapy. *Journal of Neural Transmission*, 124(1), 99–107. <https://doi.org/10.1007/s00702-016-1628-4>
- World Health Organization. (2013). *Guidelines for the management of conditions specifically related to stress*. WHO Press.
- Wilson, G., Farrell, D., Barron, I., Hutchins, J., Whybrow, D., & Kiernan, M. D. (2018). The use of eye-movement desensitization reprocessing (EMDR) therapy in treating post-traumatic stress disorder: A systematic narrative review. *Frontiers in Psychology*, 9, Article 923. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00923>
- Zang, Y., Hunt, N., & Cox, T. (2013). A randomised controlled pilot study: The effectiveness of narrative exposure therapy with adult survivors of the Sichuan earthquake. *BMC Psychiatry*, 13(1), Article 41. <https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-41>

ETHICAL DECLARATIONS

Research and Publication Ethics

The author(s) declare that this manuscript is an original work prepared in accordance with the principles of scientific research and publication ethics. The manuscript has not been previously published and is not currently under consideration for publication elsewhere. All sources used in the preparation of this study have been properly cited and referenced. The author(s) confirm that the work contains no plagiarism, fabrication, falsification, or manipulation of data. The research findings are presented honestly and transparently in accordance with the principles of academic integrity.

Author Contributions

All authors have significantly contributed to the conception, design, analysis, and preparation of the manuscript. All authors have read and approved the final version of the manuscript and agree to its submission and publication.

Conflict of Interest

The author(s) declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this manuscript.

Funding

This research did not receive any specific grant, financial support, or funding from any public, commercial, or non-profit funding agencies.

Artificial Intelligence (AI) Usage Disclosure

During the preparation of this manuscript, artificial intelligence tools may have been used solely for limited purposes such as language editing, translation assistance, and stylistic improvement. Any AI-assisted translations or language corrections were carefully reviewed and verified by the author(s). Artificial intelligence tools were not used to generate the core scientific content, research design, analysis, or scholarly conclusions. All academic responsibility for the content of the manuscript rests entirely with the author(s).

Copyright and Permissions

The author(s) confirm that all necessary permissions for copyrighted materials have been obtained where required and that the manuscript does not violate any intellectual property rights.

Author Approval

All authors confirm that they have read and approved the final version of the manuscript and consent to its submission and publication.

ETİK BEYANLAR

Araştırma ve Yayın Etiği

Yazar(lar), bu makalenin özgün bir çalışma olduğunu ve bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlandığını beyan eder. Makale daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olup başka bir dergide değerlendirme sürecinde değildir.

Çalışmada kullanılan tüm kaynaklar akademik kurallara uygun biçimde atıflanmıştır. Yazar(lar), çalışmanın intihal, veri uydurma, veri tahrifi veya manipülasyon içermediğini; araştırma bulgularının bilimsel dürüstlük ilkelerine uygun şekilde sunulduğunu beyan eder.

Yazar Katkısı

Tüm yazarlar çalışmanın tasarlanması, yürütülmesi, analizi ve makalenin hazırlanmasına önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Tüm yazarlar makalenin son hâlini okuyup onaylamış ve yayımlanmasını kabul etmiştir.

Çıkar Çatışması

Yazar(lar), bu makalenin yayımlanmasına ilişkin herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder.

Finansal Destek

Bu araştırma herhangi bir kamu kurumu, ticari kuruluş veya kâr amacı gütmeyen kuruluş tarafından finansal olarak desteklenmemiştir.

Yapay Zekâ Kullanım Beyanı

Makalenin hazırlanması sürecinde yapay zekâ araçlarından yalnızca dil düzenleme, çeviri desteği ve anlatım iyileştirmesi amacıyla sınırlı ölçüde yararlanılmış olabilir. Yapay zekâ araçları tarafından yapılan çeviri ve dil düzenlemeleri yazar(lar) tarafından dikkatle kontrol edilmiştir. Yapay zekâ araçları çalışmanın bilimsel içeriğinin, araştırma tasarımının, analizlerinin veya akademik sonuçlarının oluşturulmasında kullanılmamıştır. Makalenin içeriğine ilişkin tüm akademik sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Telif Hakları ve İzinler

Yazar(lar), telif hakkı gerektiren materyaller kullanılmışsa gerekli izinlerin alındığını ve çalışmanın herhangi bir fikrî mülkiyet hakkını ihlal etmediğini beyan eder.

Yazar Onayı

Tüm yazarlar makalenin son hâlini okuduklarını, onayladıklarını ve yayımlanmasını kabul ettiklerini beyan eder.

Copyright of Electronic Turkish Studies is the property of Electronic Turkish Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites without the copyright holder's express written permission. Additionally, content may not be used with any artificial intelligence tools or machine learning technologies. However, users may print, download, or email articles for individual use.